

عرض سعر وإتفاقية تأمين صحي

Health Insurance Proposal & Agreement

Thank you for your interest in Health Insurance program for Small & Medium Enterprises provided by MEDGULF (RIADI).

شكراً لاهتمامك في برنامج التأمين الصحي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدمة من ميدغلف (ريادي)،

We are interested in providing health insurance services that suit your needs and wish you a healthy life full of confidence and vigor by providing unparalleled care of distinguished additional services, always available to serve you at any time.

بهمة أن نوفر خدمات تأمين صحي تناسب احتياجاتك ومتمنين لك حياة صحية ممتلئة بالثقة والنشاط بتقديم رعاية لا مثيل لها من الخدمات الإضافية المتميزة، متواجدين معك دائماً لخدمتك في أي وقت.

RIADI is a partner and supporter is part of our commitment to always be by your side, we strive to provide a world of services dedicated to helping you.

ريادي شريك وداعماً لك وهو جزء من التزامنا أن نكون دائماً إلى جانبك، نبذل جهدنا على توفير عالم من الخدمات المخصص لمساعدتك.

Quotation Details	Company Name	تفاصيل العرض
Policy Holder Name:	مصنع اسفنج اليمامة للصناعة	اسم حامل الوثيقة :
C.R:	1010437823	السجل التجاري :
Quotation Number:	9647210	رقم العرض:
Insurance Policy Number:		رقم الوثيقة:
Insurance Policy Duration:	سنة واحدة / 1 Year	مدة الوثيقة:
Insurance Policy starts at:	30/09/2026	يبدأ التأمين في تاريخ:
Insurance Policy ends at:		ينتهي التأمين في تاريخ:
Download the Health Declaration:	اضغط هنا / click here	لتحميل نموذج الإفصاح الطبي:

Section	الرقم / No.	القسم
Quotation	1	عرض السعر
Table of insured Members	2	جدول الأعضاء المؤمن لهم
Table of Benefits	3	جدول المنافع
Special Conditions	4	الشروط الخاصة
Insurance Authority Health Insurance Policy	5	الأحكام والشروط الخاصة بهيئة التأمين
Global Emergency Services	6	خدمات الطوارئ العالمية

This Program is customized to fit your desires with the intention that you could benefit from our services with immediate effect.

إن هذا البرنامج صمم لكي يتناسب مع رغباتك واهتمامنا هو أن تتمكن من الاستفادة من خدماتنا بأسرع وقت ممكن.

We are pleased to enclose our Health Insurance quotation for your kind consideration. This program is designed to meet the requirements of شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ميد غلف Company, in compliance with the policy terms set by the Council of Insurance Authority.

نقدم لك عرض سعر التأمين الصحي وهذا العرض صمم ليتناسب مع متطلبات شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ميد غلف كما يتوافق مع الوثيقة الموحدة لهيئة التأمين.

1) عرض سعر التأمين:	Amount SAR المبلغ بالريال سعودي	1) Insurance Quotation:
المجموع قبل القيمة المضافة	53,881.66	Total (Before VAT)
ضريبة القيمة المضافة (15 %)	8,082.25	VAT 15%
إجمالي القسط	61,963.91	Total Premium

نظام التقسيط	النسبة / Percentage	المبلغ / Amount	تاريخ الاستحقاق / Payment Date
100 % Advanced	61,963.91	30/09/2026	

Data will be sent to the Insurance Authority upon receipt of payment due.

سيتم إرسال البيانات إلى هيئة التأمين بعد استيفاء الدفعة المستحقة.

MEDGULF will auto cancel the policy if the payment was not submitted within 30 days from the payment's due date.

ستقوم "ميدغلف" بإلغاء الوثيقة آلياً في حالة عدم سداد الدفعة المستحقة في مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ استحقاق الدفع.

Payment mothed:

طرق الدفع المتاحة :

Esal payments: the policy / Additions will be automatically activated by the system.

قناة إيصال : سيتم تفعيل الوثيقة / الإضافات تلقائياً عن طريق النظام.

Any additions premiums must be paid through the ESAL payment service. If the additions premium is not received within 15 days of the due date, the request will be automatically canceled.

يجب دفع رسوم الإضافات عبر خدمة إيصال. إذا لم يتم استلام الرسوم خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق، سيتم إلغاء الإضافة تلقائياً.

الطرف الثاني / Second Party

الطرف الأول / First Party

توقيع وختم العميل / Client's Signature & Stamp

توقيع وختم ميدغلف / MEDGULF's Signature & Stamp



2) Table Of Insured Members

جدول الاعضاء المؤمن لهم

	Schema	Name	Id	Birth Date	Age	Gender	HQ	Amount
1	Riadi Advance/MG27		2036394100	26/01/89	38	Female	0	4,804.02
2	Riadi Advance/MG27		2064429687	27/01/91	36	Female	0	4,988.06
3	Riadi Advance/MG27		2174646170	01/01/74	53	Male	0	2,360.78
4	Riadi Advance/MG27		2207415049	05/03/78	49	Male	0	1,991.51
5	Riadi Advance/MG27		2250582596	15/11/74	52	Female	0	3,622.13
6	Riadi Advance/MG27		2314188307	20/06/76	50	Male	0	4,702.01
7	Riadi Advance/MG27		2317596308	01/02/81	46	Male	0	5,908.28
8	Riadi Advance/MG27		2354569994	20/10/79	47	Male	0	2,512.24
9	Riadi Advance/MG27		2358868780	10/02/87	40	Female	0	5,798.08
10	Riadi Advance/MG27		2387770924	15/04/15	11	Male	0	2,214.40
11	Riadi Advance/MG27		2430837019	09/06/78	48	Male	0	1,991.51
12	Riadi Advance/MG27		2437696889	25/06/81	45	Male	0	1,568.63
13	Riadi Advance/MG27		2439076726	23/06/17	9	Male	0	2,214.40
14	Riadi Advance/MG27		2499791313	11/07/84	42	Male	0	4,542.77
15	Riadi Advance/MG27		2501825968	24/07/94	32	Female	0	5,854.26
16	Riadi Advance/MG27		2501825976	09/02/15	12	Female	0	2,296.94
17	Riadi Advance/MG27		2501825984	11/01/17	10	Female	0	2,296.94
18	Riadi Advance/MG27		2501825992	28/12/19	7	Female	0	2,296.94

3) Table Of Benefits

جدول المنافع

Class	Riadi Advance/MG27		الفئة
Benefit			المنفعة
Maximum annual Benefit limit per person	1,000,000		حد المنفعة الأقصى لكل شخص
Territorial Limits	K.S.A.		الحدود الإقليمية
Network type	MG27		شبكة المرافق الطبية
Emergency treatment services			خدمات العلاج الطارئة
The retained liabilities of the emergency medical treatment required by the medical condition of the beneficiary shall not be deducted following the occurrence of an event' accident or emergency health condition that calls for rapid medical intervention according to the following emergency medical care levels: (1- Resuscitation 2- Emergency 3- Urgent case' which leads to the loss of life' one or more organ or causes a temporary or permanent disability.)			مغطاة و لا يتم استقطاع أي نسبة تحمل للعلاج الطبي الطارئ الذي تقتضيه الحالة الطبية للمستفيد إثر وقوع حدث، أو عارض أو حالة صحية طارئة تستدعي التدخل الطبي السريع حسب المستويات التالية من مستويات الرعاية الطبية العاجلة (1- الإنعاش. 2 الطوارئ 3- الحالة العاجلة التي من الممكن أن تؤدي إلى فقدان الحياة أو فقدان عضو أو أكثر ، أو حدوث حالة إعاقة عارضة أو مستديمة)
Pre-Existing &Chronic Medical Conditions	Covered	مغطى	الحالات السابقة والحالات المزمنة
Out-patient treatment costs:			تقفات المعالجة بالعيادات الخارجية
The beneficiary (Insured) shall pay the deductible amount (i.e. copayment) upon a visit to an out-patient doctor' which includes all the consultations and requirements of the doctor as well as the laboratory tests' x-rays' any treatment supplies requested by it' in addition to the follow-up visit' and the referral for the same illness and not for each procedure separately' except for drugs for which the coverage limit was canceled.			يلتزم المستفيد (المؤمن له) بدفع نسبة التحمل (أي المشاركة في الدفع) عند زيارته لطبيب العيادات الخارجية، وهي شاملة جميع ما يقوم به الطبيب من مشورة وما يطلبه من فحوصات مخبرية وأشعة وأي مستلزمات ع?جبة وكذلك زيارة المتابعة و التحويل لنفس العلة وليس لكل إجراء على حده، باستثناء ا?دوية حيث تم فصل حد التغطية التأمينية لها
The deductible amount according to the provider classification			نسبة المشاركة بالدفع بحسب تصنيف مزود الخدمة
Mandatory Provider Network(MPN)	20 % Maximum 75 SAR	20 % بحد أقصى 75 ريال سعودي	(داخل شبكة الحد الأدنى الموحدة) مستشفيات و مستوصفات

Outside Hospital Network(OHN)	20 % Maximum 100 SAR	20 % بحد أقصى 100 ريال سعودي	(خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة) مستشفيات
Outside Complex Network(OCN) "Other provider "	20 % Maximum 100 SAR	20 % بحد أقصى 100 ريال سعودي	(خارج و داخل شبكة الحد الأدنى الموحدة) باقي مزودي الخدمة
Expenses of medicines prescribed by outpatient clinics:			نفقات الأدوية الموصوفة من العيادات الخارجية
The deductible amount according to the medicines prescribed type			نسبة المشاركة بالدفع بحسب تصنيف مزود الخدمة
The deductible amount (copayment): The percentage paid by the beneficiary (the Insured) upon receiving the prescribed drugs when visiting an outpatient doctor' including all prescriptions for the same illness and not for each drug separately.			نسبة التسامح (المشاركة في الدفع): النسبة التي يدفعها المستفيد (المؤمن عليه) عند استلام الأدوية الموصوفة عند زيارة الطبيب الخارجي ، بما في ذلك جميع الوصفات الطبية لنفس المرض وليس لكل دواء على حدة
Generic medicine' over-the-counter drug (OTC drug) and innovate treatment - with no generic alternative available	Deductible amount shall be 20 % Maximum Copayment payment Cap: 30 SAR	نسبة التحمل 20 % الحد الأقصى للمشاركة بالدفع 30	الدواء الجينيس و الأدوية اللاوصفية و علاج مبتكر - في حال عدم توفر البديل الجينيس
Innovative treatment - with a generic alternative	Co-payment 50 %	نسبة مشاركة 50 %	علاج مبتكر - في حال توفر بديل جينيس
Maximum doctor's consultation fees:			الحد الأقصى لآتعاب استشارة الطبيب
General Practitioner/ specialist (First Registrar Doctor).	100 - 150 SR	100 - 150 ريال سعودي	الطبيب العام الاختصاصي (طبيب نائب أول)
Specialist (Second Registrar Doctor)/ Consultant.	200 - 300 SR	200 - 300 ريال سعودي	الاخصائي (طبيب نائب ثاني) / الاستشاري
Specializations with scarcity and the like' such as cardiology' neurosurgery' vascular surgery and subspecialties according to the standards of the Saudi Commission for Health Specialties	400 SR	400 ريال سعودي	التخصصات ذات الندرة و ما في حكمها كالقلب و جراحة المخ و الأعصاب و جراحة الأوعية الدموية و التخصصات الدقيقة حسب معايير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
(The beneficiary shall be inspected according to the sequence of procedures for providing the service' unless the service is not available at the service center).			تتم معاينة المستفيد حسب تسلسل إجراءات تقديم الخدمة إلا في حالة عدم توفر (الخدمة في مركز تقديم الخدمة
Hospital admission expenses deductible(Co-payment)	NIL	لا يوجد	نفقات التنويم بالمستشفى نسبة التحمل (المشاركة في الدفع)
Room Type:	Semi Private - with maximum SR. 600 per day	بحد أقصى 600 ريال سعودي باليوم - غرفة مشتركة	نوع الغرفة
Hospital Accommodation: Daily accommodation and subsistence of patient include bed fees' nursing' visits' medical supervision and subsistence services' but it does not include the cost of medicines and medical supplies' as prescribed by the physician			التكلفة اليومية للتنويم (نوع الغرفة) حد الإقامة والإعاشة اليومي للمريض وتشمل أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات والإشراف الطبي وخدمات الإعاشة ولا يتضمن ذلك تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تصرف بأمر الطبيب
Surgeons" Anesthetists' Fees' Consultants' and Physicians' Fees' Radiotherapy and Chemotherapy Charges	Covered	مغطى	آتعاب الجراح و طبيب التخدير و الطبيب الاستشاري ، تكلفة العلاج بالأشعة و العلاج الكيماوي
Accommodation limit for patient's escort (Companions)	SR 150 per day	بحد أقصى 150 ريال سعودي/ يوم	حد الإقامة والإعاشة اليومي للمرافق
Emergency Treatment Abroad During Holiday or Business Trips (subject no exceeding 90 days per year per person)	Maximum Room and Board Limit per Day SR 600 per day	التكلفة اليومية للإقامة بالمستشفى بحد أقصى 600 ريال سعودي/ يوم	خلال الاجازات او رحلات العمل شر؟طة أن ؟ علاج الحالات الطارئة في الخارج (السنوي عن 90 يوماً للفرد الواحد؟تتعدى في مجموع
Pregnancy & Delivery Cost			نفقات الحمل والولادة
	Up to a maximum of 15,000 Saudi riyals during the policy period Complication of pregnancy and delivery is covered by the maximum benefit of the limit under this policy	حد أقصى 15,000 ريال سعودي خلال مدة الوثيقة مضاعفات الحمل و حالات الولادة مغطاة بحد المنفعة الأقصى لهذه الوثيقة	
The cost of infant on the mother policy and for Maximum 30 days from the date of birth up to the addition date on their dependent policy.	Covered	مغطى	تكاليف تغطية المواليد الجدد على وثيقة الأم وبحد أقصى 30 يوم من تاريخ الولادة .حتى يتم إضآفاتهم على الوثيقة بأثر رجعي من تاريخ الولادة
Birth and therapy of premature babies	Covered	مغطى	ولادة و معالجة الأطفال المتسررين
Dental treatment costs			تكاليف علاج الأسنان
Essential and preventive dentistry:(dental consultations' medical examinations' fillings' cleaning' teeth extraction' periodontal treatment' cleaning scaling and polishing teeth with health implications.	Covered up to 1,200 SR	مغطاة حتى 1,200 ريال سعودي	طب الاسنان الأساسي والوقائي: الإستشارات ، الفحوصات الطبية ، الحشوات ، التنظيف، خلع الاسنان ، علاج اللثة ، إزالة الجير ، التجريف وتلميع الأسنان مع الآثار الصحية
Maximum deductible payment Cap:	Nill	بدون	: نسبة التحمل
	Treatment of root canals and emergencies: Covered up to 800 SR	علاج القنوات الجذرية والحالات الطارئة مغطاة حتى 800 ريال سعودي	
Maximum deductible payment Cap:	20 %	20 % .	: نسبة التحمل
Cost of Spectacles (Eyeglasses and Frames)			تكاليف النظارات الطبية
	Up to a maximum of 400 SR for those aged 14 years and below during the policy period	بحد أقصى 400 ريال بعمر 14 سنة وأقل خلال مدة	

Functional vision corrective intervention that prevent vision loss	Covered	مغطى	تكاليف التدخلات لتصحيح النظر الوظيفي
Dialysis Costs	Up to a maximum of 180,000 SR during the policy period	بحد أقصى 180,000 ريال سعودي خلال مدة الوثيقة	تكاليف الغسيل الكلوي
Kidney Transplant Costs	Up to a maximum of 250,000 SR during the policy period	بحد أقصى 250,000 ريال سعودي خلال مدة الوثيقة	تكاليف زراعة الكلى
Psychiatric treatment costs	Up to a maximum of 50,000 SR during the policy period	بحد أقصى 50,000 ريال سعودي خلال مدة الوثيقة	تكاليف علاج الحالات النفسية
Annual Limit for transport by a licensed local ambulance	Covered	مغطى	الحد السنوي للنقل بواسطة سيارة الإسعاف المحلية المرخص لها
Emergency Licensed Ambulance Service	Covered	مغطى	خدمة سيارة الإسعاف المرخصة للحالات الطارئة
Transportation of a Deceased to His or Her Country	Up to a maximum of 10,000 SR during the policy period	بحد أقصى 10,000 ريال سعودي خلال مدة الوثيقة	إعادة جثمان المتوفي إلى موطنه الأصلي
Hearing aids costs	Up to a maximum of 6000 SR during the policy period	بحد أقصى 6000 ريال سعودي خلال مدة الوثيقة	تكاليف السماعات الطبية
Cost of acquired valvar heart disease	Up to a maximum of 150,000 SR during the policy period	بحد أقصى 150,000 ريال سعودي خلال مدة الوثيقة	تكاليف حالات التلف في صمامات القلب
Cost of organ harvesting procedures (insured donor).	Up to a maximum of 50,000 SR during the policy period	بحد أقصى 50,000 ريال سعودي خلال مدة الوثيقة	"تكاليف إجراء عملية التبرع بالأعضاء " للمتبرع (المؤمن له)
Alzheimer's costs	Up to a maximum of 15,000 SR during the policy period	بحد أقصى 15,000 ريال سعودي خلال مدة الوثيقة	تكاليف مرضى الزهايمر
Costs of Autism cases	Up to a maximum of 50,000 SR during the policy period	بحد أقصى 50,000 ريال سعودي خلال مدة الوثيقة	تكاليف حالات التوحد
Schedule of the National Newborn Screening Program to eliminate disabilities	Up to a maximum of 100,000 SR during the policy period	بحد أقصى 100,000 ريال سعودي خلال مدة الوثيقة	تكاليف البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة
Costs of disability cases	Up to a maximum of 100,000 SR during the policy period	بحد أقصى 100,000 ريال سعودي خلال مدة الوثيقة	تكاليف حالات الإعاقة
Cost of covering the operation of obesity surgery	Up to a maximum of 15,000 SR during the policy period	بحد أقصى 15,000 ريال سعودي خلال مدة الوثيقة	تكاليف تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة
The deductible amount shall be	20 %	20 % .	نسبة التحمل
Maximum deductible payment Cap:	SAR 1000	1000 ريال سعودي	: الحد الأقصى للمشاركة بالدفع
Cost of circumcision cases (male)	Up to a maximum of 500 SR during the policy period	بحد أقصى 500 ريال سعودي خلال مدة الوثيقة	تكاليف حالات الختان (للذكور)
Costs for contraception	Up to a maximum of 1500 SR during the policy period	بحد أقصى 1500 ريال سعودي خلال مدة الوثيقة	تكاليف موانع الحمل
The costs of complications resulting from a benefit treatment covered in the policy	Up to Policy Maximum Limit	بالحد الأقصى العام للوثيقة	تكاليف المضاعفات الناتجة عن علاج منفعة مغطاة بالوثيقة

4) Special Conditions	4) الشروط الخاصة
Contrary to what have been mentioned in any article/ exception in the quotation, the following terms will be applied: - Verification of Insured Members: During an active policy, Medgulf has the right to verify that the Employees (Males and Females) are registered in the official policyholder records by asking for a copy of the social insurance certificate (GOSI) for Saudi members or Jawazat printout for non-Saudis (or any other official documents to prove relationship between the employee and employer). In case proven otherwise, Medgulf has the full right to cancel the insurance of the above-mentioned members retroactively from the effective date of coverage without referring to the policyholder and debit all medical expenses acquired on the policyholder's account. - The policyholder must verify the data of all employees and their family members that are legally registered (under the sponsorship of the policyholder). Taking in consideration that the insured company will not process any request by members that are not officially registered or are not under the sponsorship of the policyholder. Therefore, Medgulf has the right to request any documents that prove the relationship between an employee and the policyholder at any time during an active policy. - Medgulf has the right to request filling a Medical Declaration (MD) form for any upgrade requests. The request will be forwarded to the underwriting department to apply additional premium if needed according to the information declared in the MD form. - The rates are based on the category distribution shown in the table of insured members. Furthermore, presumed rates that would be charged for any late addition within an Age Band/ Relation that was not submitted at the time of policy issuance are also provided above. - The rates and terms quoted are preliminary and will be subject to revision upon receipt of sufficient claims records and upon receipt of the revised members list from ELM. - For cash reimbursement claims, Medgulf will accept copies of the invoices and required documents depending on their clarity, legibility and comprehensiveness to assess the veracity and cost of the claims. Without prejudice to the foregoing, Medgulf reserves the right to require the insured to present and submit the original documents at any time. By submitting the copies of cash claim invoices/documents to Medgulf, the insured also agrees that failure to produce and submit the required original documents within a maximum period of 5 days from the official request date, may lead to rejection of the claim or debiting it to the policyholder's account if it has been settled. - Cash reimbursement for Emergency Cases outside APN (in KSA or Abroad) at 100% subject to KSA network customary charges. - Non-Emergency claims incurred outside APN in KSA or abroad will be processed on cash claim reimbursement basis at 80% subject to policy's terms and conditions, as well as customary charges of our network rating in KSA. However, In-patient claims require prior approval from Medgulf taking in consideration that cash claims reimbursement is not applicable for Dental & Optical claims. - For Cash Claims, the following documents should be submitted within 120 days from the date of treatment: • Duly filled-in Cash Reimbursement Claim Form. • Original detailed invoices for each value paid, provided with the payment receipt. • Detailed medical report describing the medical condition. • Discharge report for In-patient cases. • Medical prescriptions. • Results of diagnostic tests. - No Cash Reimbursement for the assigned providers network.	خلافا لما ورد في أي بند/استثناء في عرض الأسعار، يتم تطبيق الشروط التالية: - التحقق من بيانات منسوبي حامل الوثيقة: فإنه يحق لشركة ميدغلف خلال مدة سريان الوثيقة التحقق من أن (الموظفين والموظفات) مدرجين في سجلات حامل الوثيقة النظامية عن طريق طلب شهادة المدد والأجور (شهادة التأمينات الاجتماعية) بالنسبة للسعوديين وسجل الجوازات بالنسبة لغير السعوديين، بالإضافة إلى طلب أية وثائق رسمية تثبت علاقة الموظف بصاحب العمل. وفي حال ثبوت خلاف ذلك؛ فإن للشركة كامل الحق بإلغاء التأمين الصحي بأثر رجعي من تاريخ بداية التغطية للموظف وأفراد أسرته (إن وجد) من دون الرجوع لحامل الوثيقة، وبالتالي تسجيل أية مصاريف طبية مسجلة على حساب حامل الوثيقة. - يتوجب على حامل الوثيقة التأكد من بيانات موظفيه وأفراد عائلاتهم بإدراجهم وبصورة نظامية في سجلاته وتحت كفائه، مع العلم بأن الشركة لن تقوم بتنفيذ أو الموافقة على أي طلب لأي موظف لا يدرج في سجلات حامل الوثيقة أو ليس على كفائه. وعليه ستقوم بطلب أية وثائق تثبت علاقة الموظف بصاحب العمل في أي وقت خلال مدة سريان الوثيقة. - يحق لشركة "ميدغلف" طلب تعبئة نموذج الإفصاح الطبي لطلبات الترقية وتحويل الطلب إلى قسم الاكتتاب لدراستها وتطبيق قسط إضافي إذا لزم الأمر بناءً على المعلومات الواردة في النموذج. - الأسعار مبنية على توزيع الفئات بحسب جدول "الأعضاء المؤمن لهم". إضافة إلى ذلك، الأسعار المقترضة لأي إضافة بعد سريان الوثيقة ضمن الشرائح العمرية/ العلاقة التي لم تكن متوفرة منذ بداية الوثيقة موجودة ضمن الجدول أعلاه. - الأقساط والشروط المذكورة في عرض الأسعار مبدئية وسوف تخضع للمراجعة عند استلام تقرير المطالبات للجنة المنصرمة و عند استلام قائمة الأفراد التي تم مراجعتها بنظام علم. - في حالة المطالبات النقدية، يتم قبول صور الفواتير والمستندات المطلوبة طالما أنها واضحة وكاملة وتتضمن جميع التفاصيل اللازمة لتقييم صحة وقيمة التكاليف المدفوعة. مع عدم الإخلال بما سبق، تحتفظ ميدغلف بالحق في مطالبة المؤمن له بنزولها بالنسخ الأصلية لهذه المستندات في أي وقت. - عند تقديم صور المستندات والفواتير، فإن المؤمن له يقر بأن عدم تسليم المستندات الأصلية في مدة أقصاها ٥ أيام من تاريخ طلبها سيؤدي إلى رفض المطالبة أو تسجيلها على حساب حامل الوثيقة إذا تم تسويتها من قبل. - تغطية مصاريف العلاج للحالات الطارئة ١٠٠٪ في المرافق غير المعتمدة (داخل أو خارج المملكة العربية السعودية) حسب أسعار المرافق الطبية المعتمدة في الشبكة. - تغطية الحالات غير الطارئة لجميع المنافع خارج شبكة المرافق المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وسيتم التعويض عن هذه المطالبات بنسبة ٨٠٪ حسب شروط وأحكام الوثيقة والأسعار المعقولة والرائجة لدى شبكة المرافق الطبية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، كما يشترط الحصول على موافقة مسبقة من شركة "ميدغلف" لحالات التنويم، علماً بأنه لن يتم تطبيق مبدأ التعويض النقدي لعلاج الأسنان والنظر. - للمطالبات النقدية، يتوجب مراعاة وتقديم المستندات التالية خلال ١٢٠ يوماً من تاريخ العلاج: • تعبئة نموذج تعويض المطالبات النقدية. • النسخة الأصل من الفواتير المفصلة لكل قيمة مدفوعة بالإضافة إلى سند الدفع. • تقرير طبي مفصل يوضح الحالة الصحية. • تقرير الخروج من المستشفى بعد التنويم. • الوصفة الطبية للأدوية. • نتائج التشخيص. - لن يتم التعويض النقدي لتكاليف العلاج في المرافق الطبية المعتمدة.

5) Health insurance terms and conditions	5) الأحكام والشروط الخاصة بالضمان الصحي
Compulsory Basic Cover	الغطاء الإلزامي المودع

In execution of the Cooperative Health Insurance System issued by Royal, decree No m/10 dated 1/5/1420 h and its amended execution list issued by decision of the Minister of Health No. D/1/30/6131 dated 8/6/1430 h and o Ministerial Resolution No. 1443-006869 in this respect, and whereas the Policyholder has presented to MedGulf -The Mediterranean & Gulf Cooperative Insurance & Reinsurance Company CO. (S.J.S.C) (hereinafter called the Company) a written application (which shall form the basis of this policy and forms an integral part thereof) for the purpose of obtaining the insurance cover described hereafter for himself and his dependents or for his employees and their dependents whose names are shown in the attached list and are called hereafter the beneficiaries, and has paid or agreed to pay the premium, The Company agrees with the Policyholder, based on the above, to cover the costs of providing healthcare to the beneficiaries under this policy to the extent and in the manner described herein through the network of medical providers appointed by the Company subject to the terms, conditions, definitions and limits of cover included in this policy or in any endorsement (approved by the Insurance Authority) that may be agreed upon later.

We refer to your duly signed proposal form dated << >> along with the signed declaration form " if any " for availing insurance cover from MedGulf -The Mediterranean & Gulf Cooperative Insurance & Reinsurance Company (hereinafter referred to as the " Company / We / US as maybe used interchangeably). Based on the said proposal form, we are pleased to inform you that your proposal for insurance has been accepted by us.

Based on the underwriting policies of MEDGULF, we are pleased to offer our insurance services to you as per the below mentioned premium quotation.

Section I: Definitions

The terms and expressions mentioned herein shall have the meanings ascribed thereto, and expressions that are not defined herein shall have the same meanings ascribed thereto in the Law or the Implementing Regulations:

1. Kingdom: Kingdom of Saudi Arabia
2. Authority: Insurance Authority.
3. Law: The Cooperative Health Insurance Law applied in the Kingdom.
4. Executive regulations: Executive bylaw Regulation.
5. Policy: This basic health insurance policy, including its schedule, appendices, and annexes.
6. Health insurance: Health insurance is established by the Law and its implementing regulation under this policy, with its schedule, appendices, or annexes and it is practiced by cooperative insurance companies licensed to operate in the Kingdom under the Insurance Companies Control Law.
7. Health insurance term: The period indicated in the policy schedule for which health insurance remains valid.
8. Effective period: The number of days during which the policy will be effective if the full subscription indicated in the policy schedule is not paid.
9. Start date: The date indicated in the policy schedule at which insurance coverage begins.
10. Effective date: The date on which a person becomes eligible for coverage under this policy or to add or delete an insured person in the policy.
11. Benefit: Cost of providing healthcare services included in the insurance coverage within the limits indicated in the policy schedule
12. Insurance coverage: Basic health benefits available to the beneficiary as specified in the policy
13. Coverage limits: The maximum liability of the insurance company as specified in the policy schedule for any insured person before applying the deductible.
14. Insurance parties: Insurance Company, brokerage firm, service providers, revenue cycle Management Company, third-party administrators (TPAs), policyholder, beneficiary and anyone considered a party to the insurance parties under the Executive Regulations.
15. Insurance company: A cooperative insurance company licensed by Insurance Authority to operate in the Kingdom and accredited by the Insurance Authority to provide cooperative health insurance.
16. Policy Holder: A natural or corporate person in whose name the policy is issued
17. Beneficiary or insured: A natural person (or persons) to whom coverage is provided under the policy.
18. Employer: A natural or corporate person employing one or more employees
19. Employee: Every natural person working for and under the management and supervision of an employer in return for a wage, even if the employee is not under his immediate supervision
20. Dependent(s): Husband or wife, sons up to the age of twenty-five and unmarried daughters in addition to orphans who are fostered by foster families, receiving compulsory health insurance.
21. Service provider: healthcare facilities (governmental/non-governmental) licensed to provide healthcare services in the Kingdom under relevant laws and rules approved by the Insurance Authority, such as hospitals, general, and specialized medical complexes, diagnostic centers, clinics, pharmacies, laboratories, physiotherapy, or radiotherapy centers.
22. Preferred Provider Network (PPN): A group of healthcare service providers approved by the IA and specified by the insurance company to provide healthcare services to the insured. These services are directly credited to the insurance company's account. This network includes the following levels of health services:
 - Level 1 (primary health care).
 - Level 2 (public hospitals).
 - Level 3 (specialized or reference hospitals).
 - Other complementary health service provider centers (such as One- day surgery centers, pharmacies, physiotherapy centers, eyeglasses shops, Telemedicine, Home health care).
23. A hospital: A health facility approved by the IA, accepted by the policyholder and the insurance company, and licensed to work as a hospital under the regulations to provide health services for which compensation may be claimed under this policy.
24. Licensed doctor: Practicing the medical profession with the appropriate scientific qualification according to the classification of the Saudi Commission for Health Specialties (SCFHS) and is licensed to practice the medical profession by the Ministry of Health.

تنفيذاً لنظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ١٠ وتاريخ ١٤٢٠/٥/١٥ هـ ولانحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم ١٣٠ / ٦١٣١ / ١٤٣٠ هـ و إشارة الى القرار الوزاري رقم (1443 - 006869) و تاريخ 13/08/1443 هـ في هذا الشأن.

وبما ان حامل الوثيقة قد تقدم إلى شركة ميدغلف - شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ش.م.س)، (ويشار إليها فيما بعد بالشركة) بطلب خطي (سيشكل أساساً لهذه الوثيقة وجزءاً لا يتجزأ منها)، بغرض إجراء التأمين الموصوف لاحقاً عليه ومُعالجته أو على موظفيه ومُعالجهم المدرجة أسماؤهم في القائمة المرفقة بهذه الوثيقة والمشار إليهم فيما بعد بالمؤمن عليهم، وقد سدد الاشتراك أو وافق على تسديده.

فإن الشركة تتفق بموجب ما أُشير إليه بعاليه مع حامل الوثيقة على تغطية نفقات توفير الرعاية الصحية للمؤمن عليهم بموجب هذه الوثيقة، وإلى المدى وبالطريقة المبيّنين بها، من خلال شبكة مقدمي الخدمة المعيّنين من قبل شركة التأمين مع الخضوع في ذلك دوماً لاشتراطات وتعريفات وتحددات وحدود التغطية التي تشتمل عليها هذه الوثيقة وأية ملاحق إضافية (مقرة من هيئة التأمين) يتفق عليها لاحقاً.

بالإشارة إلى نموذج طلب التأمين الموقع من قبلكم و المؤرخ بـ << >> والمرفق به نموذج الإفصاح الطبي " في حال طلبه " وذلك للحصول على التغطية الطبية من شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة تأمين التعاوني ميدغلف (يشار إليها هنا و فيما بعد بـ "الشركة" / "نحن" / "لنا"). وبناءً على نموذج طلب التأمين المقدم من قبلكم، يسرنا ابلاغكم بقبول الشركة لتقديم التغطية التأمينية الخاص بكم وبناءً على سياسة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة تأمين التعاوني ميدغلف للاكتتاب، يسرنا تقديم العرض الخاص بخدماتنا التأمينية وفقاً للمعلومات المرسلة من قبلكم .

التعريفات

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه الوثيقة المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتضي السياق خلاف ذلك، ويكون للعبارات التي لم يتم تعريفها ذات المعاني الموضحة لكل منها في النظام أو اللائحة التنفيذية:

1. المملكة: المملكة العربية السعودية.
2. الهيئة: هيئة التأمين.
3. النظام: نظام الضمان الصحي التعاوني المطبق في المملكة.
4. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام.
5. وثيقة الضمان: الوثيقة الصحية الأساسية هذه، بما في ذلك جدولها وملاحقها ومرفقاتها.
6. التأمين الصحي: التأمين الصحي الذي يقرره النظام ولانحته التنفيذية بموجب هذه الوثيقة مع جدولها وملاحقها أو مرفقاتها وتقدمه شركات التأمين التعاوني المرخص لها بالعمل في المملكة وفقاً للنظام مراقبة شركات التأمين.
7. مدة التأمين الصحي: المدة المبينة في جدول الوثيقة التي يبقى فيها التأمين الصحي ساري المفعول .
8. مدة سريان المفعول: عدد الأيام التي ستكون الوثيقة خلالها نافذة المفعول في حالة عدم سداد كامل الاشتراك المبين في جدول الوثيقة.
9. تاريخ الابتداء: التاريخ المبين في جدول الوثيقة والذي تبدأ عنده التغطية التأمينية.
10. تاريخ السريان: التاريخ الذي يصبح فيه الشخص مؤهل للتغطية بموجب هذه الوثيقة أو إضافة أو حذف شخص مؤمن له في الوثيقة.
11. المنفعة: نفقات توفير الخدمة الصحية التي تشملها التغطية التأمينية ضمن الحدود المبينة في جدول الوثيقة .
12. التغطية التأمينية: المنافع الصحية الأساسية المتاحة للمستفيد والمحددة في هذه الوثيقة.
13. حدود التغطية: الحد الأقصى لمسؤولية شركة التأمين كما هو محدد في جدول الوثيقة بالنسبة لأي شخص مؤمن له وذلك قبل تطبيق نسبة التحمل.
14. أطراف العلاقة التأمينية: شركة التأمين، وشركة الوساطة، ومقدمي الخدمة، وشركة إدارة دورة الإيرادات، وشركة إدارة المطالبات، وحامل الوثيقة، والمستفيد وكل من يعتبر طرفاً في العلاقة التأمينية وفقاً لللائحة التنفيذية.
15. شركة التأمين: شركة التأمين التعاوني المرخص لها بالعمل في المملكة من قبل هيئة التأمين والمؤهلة لممارسة نشاط الضمان الصحي التعاوني من قبل هيئة التأمين.
16. حامل الوثيقة: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي صدرت الوثيقة باسمه.
17. المستفيد أو المؤمن له: هو الشخص الطبيعي (أو الأشخاص الطبيعيين) الذي تقررت التغطية التأمينية الصحية لصالحه بموجب هذه الوثيقة.
18. صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغل عاملاً أو أكثر مقابل أجر وفقاً لنظام العمل.
19. العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته.
20. المآل: الزوج أو الزوجة، والأولاد الذكور حتى سن الخامسة والعشرون، والبنات غير المتزوجات بالإضافة إلى الأيتام المحتضنين لدى الأسر الكافلة المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي.
21. مقدم الخدمة: المرفق الصحي (الحكومي وغير الحكومي) المؤهل نظاماً والمرخص له بتقديم الخدمات الصحية في المملكة وفقاً للأنظمة والقواعد ذات العلاقة، والمعتمد من هيئة التأمين، وعلى سبيل المثال لا الحصر: مستشفى، مجمع طبي عام، مجمع طبي متخصص، مركز تشخيص، عيادة، صيدلية، مختبر، مركز علاج طبيعي أو مركز علاج الإشعاع.
22. شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة: مجموعة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين من الهيئة والمحددن من قبل شركة التأمين لتقديم الخدمة للمؤمن له، ويتم قيد هذه الخدمات مباشرة على حساب شركة التأمين، على أن تتضمن هذه الشبكة مستويات الخدمات الصحية التالية:
 - المستوى الأول (الرعاية الصحية الأولية).
 - المستوى الثاني (المستشفيات العامة).
 - المستوى الثالث (المستشفيات التخصصية أو المرجعية).
23. مراكز تقديم الخدمات الصحية الأخرى المكملة (مثل: مراكز جراحة اليوم الواحد، الصيدليات، مراكز العلاج الطبيعي، محلات النظارات، الخطب الاتصالي، الرعاية المنزلية).
24. المستشفى: مرفق صحي معتمد من الهيئة، ومقبول من حامل الوثيقة وشركة التأمين ومرخص له بالعمل كمستشفى وفقاً للأنظمة المعمول بها لتقديم الخدمات الصحية التي قد يطلب بالتعويض عن تكاليفها بموجب هذه الوثيقة.
25. الطبيب المرخص: مزاول مهنة الطب الحاصل على المؤهل العلمي المناسب حسب تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والمرخص له بمزاولة مهنة الطب من قبل وزارة الصحة.
26. الرعاية الأولية: الخدمات الصحية التي تقدم من قبل فرق طبية تحت إشراف ممارسين مؤهلين بحيث تكون هذه الخدمات شاملة، مستمرة، منسقة ومبنية على أساس الرعاية الحكيمة. وتتراوح الرعاية الأولية بين الإرشاد والوقاية إلى علاج الأمراض العضوية والنفسية لجميع الأعمار والفئات من المستفيدين، بالإضافة إلى وخدمات رعاية الأمومة وصحة الطفل وإعادة التأهيل والرعاية التلطيفية وخدمات الرعاية العاجلة ورعاية الأمراض المزمنة والصحة السكانية وغيرها بحسب احتياج المستفيدين المسجلين لدى مقدمي خدمة الرعاية الأولية ووفقاً لأفضل الممارسات الطبية المعتمدة.
27. العلة: المرض أو الداء الذي يصيب الشخص المؤمن له قبل وخلال مدة التأمين الصحي ويتطلب بالضرورة الحصول على معالجة طبية من طبيب مرخص.
28. الحادث: الواقعة التي تحدث فجأة وغير المتوقعة في مسار الحياة العامة خلال مدة التأمين الصحي.

25. Primary care: Health services provided by medical teams under the supervision of qualified practitioners so that these services are comprehensive, continuous, coordinated and based on Value-Based Healthcare. Primary care ranges from counseling and prevention to treatment of organic and psychological diseases for all ages and categories of beneficiaries, maternity care and child health services, rehabilitation, palliative care, urgent care services, chronic disease care, population health and others as needed to serve beneficiaries registered with primary care providers and under approved medical best practices.

26. Disease: Illness or conditions that affects the insured person and necessarily requires medical treatment from a licensed doctor before and during the period of health insurance.

27. Accident: The sudden and unexpected, unforeseen, occurrence physical event during the health insurance period.

28. Traffic accident: Any accident that results in serious or light damage or partial or total material loss to property inadvertently due to the use of the vehicle while in motion.

29. Vehicle: Every means of transport on wheels or track, and are driven or carried by automatic or animal force, including any mechanical or electric vehicle, whether it is a car or bus, private or public.

30. Employment "occupational" injury: Any accident suffered by the beneficiary during performance or because of his work, or on his way from his dwelling to his workplace and back, or on his way from his workplace to the place where he usually takes his meal or gives his prayer and back, or the disease established to be caused by work. The occupational disease duly determined in accordance with the occupational diseases schedule, taking into account the date of the first medical diagnosis of the disease is regarded as the date on which the injury is sustained.

31. Personal risks: Any act or practice performed by a person is recognized as a risky activity if it carries a risk of illness or accident or is expected to cause complications of a previous illness or injury that are a result of actions not associated with the work of the insured or regular daily practices such as: dangerous sports (judo, boxing, karate, wrestling, combat sports), motor, boat and motorcycles racing, paragliding, parachuting.

32. Emergency: Urgent medical treatment required by the medical condition of the insured as a result of an accident or a case requiring prompt medical attention, depending on the following levels of urgent medical care (1. Resuscitation, 2. Emergency, 3. Urgent condition that may be resulting in death, loss of one or more organs, or the occurrence of an accidental or permanent disability situation) as described by the Private Health Institutions Law and Regulations approved by the Ministry of Health, which determines how to dispatch emergency cases.

33. Outpatient treatment: The beneficiary visits outpatient clinics for diagnosis or medical treatment.

34. Day care surgery or treatment: A patient admitted during the course of a day with the intention of receiving care who does not require the use of a hospital bed overnight and who returns home as scheduled. It should be noted that their coding and pricing is in accordance with the hospital's procedure for admission

35. Inpatient (hospital admission): Registration of the insured person as a patient for admission in the hospital until at least the next morning, including a Patient admitted with this intention who leaves hospital for any reason without staying overnight

36. Long-term care: A variety of services that include medical and non-medical care provided to people who are unable to perform activities essential to daily living for people suffering from a chronic illness or disability, or cannot care for themselves for long periods. long-term care focuses on individual and coordinated services that promote independence, improve patients' quality of life, and meet patients' needs over a long period.

37. Telemedicine: Using electronic information and communication technology means to provide diagnostic, screening, and medical inspection services to the patient, including, for example, telemedicine and health using smartphones (Health Mobile). Other forms telemedicine includes (teleconsultation, tele-expert consultation, remote assistance, other medical opinions)

38. Alternative medicine (complementary): A variety of healthcare systems, practices and products that are not part or extension of modern medical practice. Complementary medicine is used in conjunction with modern medicine, while alternative medicine is not used with modern medicine at the same time. Examples include but are not the limited to herbal treatment, cupping, Chinese medicine, hypnosis, osteopathy, chiropractic, acupuncture.

39. Health: A state of complete physical, mental and social health, not just lack of illness or disability.

40. Allergies: In particular, the individual is sensitive to certain types of food, medicine, weather, pollen or any other triggers from plants, insects, animals, minerals, elements or other substances. The individual experiences physical reactions caused by direct or indirect contact with those substances that cause conditions such as asthma, dyspepsia, friction, hay fever, eczema, and headache.

41. Congenital Defect: Functional, chemical or structural dysfunction that is usually present before birth, whether through heredity or as a result of environmental factors according to medical custom.

42. Pregnancy and childbirth: Any pregnancy or birth, including natural, cesarean and abortion.

43. Preterm Baby: a baby born before the 37th week of pregnancy (three weeks before the birthdate)

44. Psychological cases: A disorder of thinking, mood, perception, memory or mental abilities, some or all of them.

45. Disability cases: Disability means having a total or partial impairment permanently or for a long period of life in one of the physical, sensory, mental, communicative, educational or psychological abilities, and causes that the disabled person cannot meet the requirements of normal life and rely on others to meet them. Or the need for a special tool that requires training or special qualification for its proper use.

46. Vision correction interventions: Interventions to improve vision and have no effect to prevent vision loss such as LASIK, lenses and eyeglasses

47. Functional vision correction interventions: Interventions to improve vision that are important for vision preservation "avoiding vision loss". For example, strabismus and Amblyopia procedures for children less than 14 years and keratoconus, cataract, glaucoma for all age groups.

48. Human organ: Any part of the human body (dead or alive), its tissues or any of its components, which can be used by transplanting them into another human body, except for blood.

49. Transplant of Human Organs: A medical operation through which the human organ

28. حادث سير: كل حادث ينتج عنه أضرار جسيمة أو خفيفة أو خسائر مادية جزئية أو كلية في الممتلكات دون قصد، جراء استخدام المركبة وهي في حالة حركة، كما هو منصوص عليه في الأنظمة المختصة وذات العلاقة.

29. المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل التي اعتد للسير على عجلات أو جنزير، وتسير أو تجر بقوة آلية أو حيوانية، بما في ذلك أي مركبة ميكانيكية أو كهربائية سواء كانت سيارة أو حافلة، خاصة أو عامة.

30. إصابة "حادث": عمل: الحادث الذي يقع للمؤمن له بسبب العمل أو أثناءه أو بسبب تنقلاته من السكن إلى العمل والعودة منه أو نتيجة قيامه بمهمة عمل أو أثناء ذهابه لتناول طعامه أو تادية صلاته أو الأمراض التي يثبت أن سببها العمل، كما بعد تاريخ أول تشخيص طبي للمرضى في حكم تاريخ الإصابة.

31. الأخطار الشخصية: أي فعل أو ممارسة يقوم بها الشخص والمتعارف عليها كششاط خطر ومنطوي على مخاطر التعرض للإصابة بمرض أو حادث، أو متوقع أن يسبب مضاعفات المرض أو إصابة سابقة وتكون نتيجة لأعمال غير مرتبطة بأعمال المؤمن له أو الممارسات اليومية الاعتيادية مثل: الرياضات الخطرة (الجمود، الملاكمة، الكاراتيه، المصارعة، الرياضات القتالية)، سباقات السيارات والقوارب والدرجات النارية، الطيران الشراعي، الغفر المطلي وتسلق الجبال.

32. الحالة الطارئة: العلاج الطبي الطارئ الذي تقتضيه الحالة الطبية للمستفيد إثر وقوع حدث، أو عارض، أو حالة صحية طارئة تستدعي التدخل الطبي السريع، وذلك حسب المستويات التالية من مستويات فرز الرعاية الطبية العاجلة (1- الإنعاش، 2- الطوارئ، 3- الحالة العاجلة التي من الممكن أن تؤدي إلى فقدان الحياة، أو فقدان عضو أو أكثر، أو حدوث حالة إعاقة عارضة أو مستديمة) كما هو موضح بنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية المعمدة من وزارة الصحة والذي يحدد كيفية فرز الحالات الطارئة.

33. المعالجة في العيادات الخارجية: زيارة المستفيد للعيادات الخارجية بغرض التشخيص أو المعالجة الطبية من علة.

34. جراحة أو معالجة اليوم الواحد: الجراحة أو المعالجة التي تتطلب بالضرورة الإعداد المسبق للدخول في مركز معالجة ليوم واحد، ولكنها لا تتطلب التنويم حتى اليوم التالي. علما بأن ترميزها وتسعيرها يكون وفقا للآلية المتبعة لدى المستشفى للتنويم.

35. التنويم في المستشفى: تسجيل الشخص المؤمن له كمرضى منوم في المستشفى حتى صباح اليوم التالي على الأقل بما في ذلك المرضى الذي يتم قبوله بهذه النية ويغادر المستشفى لأي سبب دون المبيت.

36. الرعاية المديدة (رعاية طويلة المدة): مجموعة متنوعة من الخدمات التي تشمل الرعاية الطبية وغير الطبية المقدمة للأشخاص غير القادرين على أداء الأنشطة الأساسية للعيش اليومي (Activity of daily living) للأشخاص الذين يعانون من مرض مزمن أو إعاقة، أو لا يستطيعون رعاية أنفسهم لفترات طويلة، حيث تركز الرعاية طويلة الأجل على الخدمات الفردية والمنسقة التي تعزز الاستقلال، وتحسين جودة حياة المرضى، وتلبية احتياجات المرضى على مدى فترة زمنية طويلة.

37. الرعاية الصحية عن بعد (الطب الاتصالي): استخدام وسائل تقنية المعلومات والاتصالات الإلكترونية لتقديم خدمات التشخيص والفحص والعناية الطبية للمريض وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الرعاية الصحية عن بعد والصحة باستخدام الهواتف الذكية (Health Mobile) كما تعتبر من صور الطب الاتصالي (الاستشارة عن بعد، استشارة خبير عن بعد، المساعدة عن بعد، رأي طبي آخر).

38. الطب البديل (التكميلي): مجموعة طبية متنوعة من أنظمة الرعاية الصحية والممارسات والمنتجات التي لا تعتبر جزءاً أو امتداداً للممارسة الطبية الحديثة. ويستعمل الطب التكميلي جنباً إلى جنب مع الطب الحديث، بينما لا يكون هناك استعمال الطب البديل مع الطب الحديث في أن واحد، وعلى سبيل المثال لا الحصر العلاج بالأعشاب، الحجامة، والطب الصيني، التنويم المغناطيسي، تقويم العمود الفقري (Osteopathy)، تقويم العمود الفقري (Chiropractic)، الوخز الإبري، بالإضافة إلى مجموعة من الممارسات الأخرى.

39. الصحة: حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرد انعدام المرض أو العجز.

40. الحساسية: تحسس الفرد، بصفة خاصة، لأنواع معينة من الغذاء، الدواء، الطقس، غبار الطلع أو أي محدثات أخرى من النباتات، الحشرات، الحيوانات، المعادن، العناصر أو المواد الأخرى حيث يعاني الفرد ردود فعل بدنية يسببها الاتصال المباشر أو غير المباشر بتلك المواد مما يتسبب في حالات مثل الربو، سوء الهضم، الحكة، حمى القش، الأكزيما، الصداع.

41. التشوه الخلقي: الخلل الوظيفي أو الكيماوي أو البنائي الذي يكون موجوداً عادة قبل الولادة سواء بالوراثة أو نتيجة للعوامل البيئية حسب العرف الطبي.

42. الحمل والولادة: أي حالة حمل أو ولادة، ويشمل ذلك الولادة الطبيعية والقيصرية والإجهاض.

43. الطفل الخديج (المبتسر): الطفل المولود قبل الأسبوع 37 (قبل ثلاثة أسابيع من تاريخ الولادة).

44. الحالات النفسية: اضطراب في التفكير أو المزاج أو الإدراك أو الذاكرة أو القدرات العقلية بعضها أو كلها.

45. حالات الإعاقة: الإعاقة تعني الإصابة بقصور كلي أو جزئي يشكل دائم أو لفترة طويلة من العمر في إحدى القدرات الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية وتتسبب في عدم إمكانية تلبية متطلبات الحياة العادية من قبل الشخص المعاق واعتماده على غيره في تلبيةها، أو احتياجه لأداة خاصة تتطلب تدريباً أو تأهيلاً خاصاً لاستخدامها.

46. إجراءات تصحيح النظر: إجراءات لتحسين مستوى الإبصار مثل تشطيب القرنية والعدسات والنظارات الطبية والتي ليس لها أثر ملموس لفقدان الإبصار.

47. إجراءات تصحيح النظر الوظيفي: هي إجراءات علاج العين الضرورية لمنع فقد البصر على سبيل المثال عمليات الحول والغشش "Amblyopia" للأطفال دون سن 14 سنة، الماء الأزرق والماء الأبيض والقرنية المخروطية "keratoconus, cataract, glaucoma" لجميع الأعمار.

48. العضو البشري: هو أي جزء من أجزاء جسم الإنسان (المتوفى أو الحي) أو أنسجته أو أي من مكوناته، والتي يمكن الانتفاع منها بزرعها في جسم إنسان آخر، ويستثنى من ذلك الدم.

49. زراعة/نقل الأعضاء البشرية: عملية طبية يستأصل من خلالها العضو البشري أو جزء منه من جسم المتبرع ويزرع في جسم المتبرع له، بأي وسيلة طبية ومعتمدة.

50. إعادة التأهيل: جزء أساسي للرعاية الصحية الشاملة وتطبيقاتها من أجل إعادة الشخص الذي يعاني من ضعف أو قصور أو خلل عارض أو مستمر إلى أفضل مستوى من الأداء في حياته.

51. علاج الأسنان الأساسي: تشمل أي من الإجراءات الطبية التالية: 1. العناية الوقائية (استشارات وفحوصات الأسنان التنظيف، إزالة الجير (Scaling) وتلميع الأسنان)، 2. الإجراءات العلاجية (الحشوات، علاج اللثة، خلع الأسنان).

52. الجراحة الترميمية: هي إجراء الجراحة التجميلية الترميمية لتصحيح العيوب أو التشوهات أو الإصابات الناجمة عن حادث، أو عدوى، أو ورم، أو مرض.

53. الدواء أو العلاج المبتكر: (Innovative "Brand" Name) المستحضرات التي تحتوي على مادة فعالة جديدة ويتم طرحها تحت اسم تجاري في الأسواق من قبل الشركة المبتكرة.

54. الدواء أو العلاج الجيني: (Generic Name) مستحضر مكافئ للمستحضر المبتكر في الشكل الصيدلاني والتكرير وطريقة تناول الجودة والفعالية والإدعاء العلاجي.

55. القسط (الاشتراك): هو المبلغ الواجب أدائه لشركة التأمين من قبل حامل الوثيقة مقابل التغطية التأمينية التي توفرها الوثيقة خلال مدة التأمين الصحي.

56. نسبة التحمل (المشاركة في الدفع): الجزء الذي يلتزم المستفيد بدفعه عند تلقي خدمات الرعاية الصحية في العيادات الخارجية حسب ما هو منصوص عليه (إن وجد) في جدول الوثيقة، عدا الحالات الطارئة والتنويم.

57. أساس التقييم المباشر أو على حساب شركة التأمين: تسهيلات عدم الدفع الموفرة للأشخاص المؤمن لهم لدى مقدم أو مقدمي الخدمة المعيّنين من قبل شركة التأمين حيث يتم وفقاً لذلك قيد جميع تلك المصاريف مباشرة على حساب شركة التأمين.

58. أساس تعويض البديل: الأسلوب المتبع لتعويض حامل الوثيقة عن النفقات القابلة للاستعاضة التي يتحملها المؤمن له ويقدم عنها مطالبة، وذلك بعد تطبيق نسبة التحمل.

59. النفقات القابلة للاستعاضة: المصاريف الفعلية المنفقة مقابل خدمات ومواد وأجهزة غير مستتابة بموجب القسم

is removed, or part of it, from the donor's body and implanted in the patient's body, by any medical and approved means.

50. Rehabilitation: An essential part of comprehensive health care and its applications to return a person suffering from an occasional or persistent weakness, failure, or defect to the best level of performance in their family and social life in line with the definition of health and the application of best approved medical practices.

51. Essential Dental Procedures: Any of the following medical procedures that include 1. Preventative services (dental consultations, annual examination of teeth and assessment of their problems, cleaning each beneficiary once a year (including fluoride), 2. Treating procedures include (fillings, periodontal treatment, teeth extract).

52. Reconstructive surgery: Reconstructive plastic surgery is performed to correct defects, abnormalities or injuries caused by an accident, infection, tumor or disease.

53. Innovative "Brand" Name: Preparations that contain a new active substance and are offered under a brand name on the market by the innovative company.

54. Generic medication or treatment: is a product equivalent to the innovative product in pharmaceutical form, concentration, method of administration, quality, effectiveness, and therapeutic claim.

55. Premium (subscription): Amount paid by the policyholder to the insurance company for the insurance coverage provided by the policy during the insurance term.

56. Deductible (Co-payment): Amount, if any, payable by the beneficiary upon receiving outpatient treatment as specified in the policy schedule, excluding emergencies and inpatient treatment.

57. The basis of the direct entry or in company's account: Facilities of non-payment appointed by the company and available for the insured. All expenses incurred at the facilities are directly debited from the company's account.

58. Allowance compensation basis: The method used to compensate the policyholder for the reimbursable expenses incurred by the insured and submitted a claim for them, after applying the deductible.

59. Reimbursable Expenses: Expenses paid in return for services, materials and equipment not excluded under Chapter 3 of this policy that is prescribed by a licensed physician due to the illness of the insured, provided such expenses are necessary, reasonable, and normal in the relevant time and place based on best approved medical practices.

60. Claim: A request, accompanied by supporting financial and medical documents, submitted to the insurance company or representative thereof by the service provider, the insured or the policyholder for indemnification of expenses of healthcare services covered by the policy.

61. Supporting documents for a claim: All documents proving the insured's age, weight and height, nationality, identity, the validity of insurance coverage, the circumstances of the occurrence of the event resulting from that claim and proof of reimbursement of costs. It also includes other documents such as a police report, invoices, receipts, prescriptions, doctor's report, referral and recommendations, and any other relevant documents the insurance company may request.

62. Fraud: when any of the Insurance Parties performs or refrains from performing an act aimed at gaining an unfair or unlawful advantage for the benefit of the fraudster or other parties, or an act that involves fraud or deception that results from obtaining benefits or money, or providing benefits excluded or exceeding the permissible the limits to an individual or entity, and the like, according to the Law and Regulations.

63. Abuse: Practices by any insurance party which may lead to obtaining benefits or privileges they are not eligible to receive; without the intent to defraud, deceive, misrepresent, or distort facts to obtain such benefits and privileges and what comes under it under the Implementing Regulations, for example but Not limited to - exaggerating diagnostic tests and medications.

64. Negligence: Providing insurance/medical procedures without exercising the duly recognized reasonable amount of medical or insurance precautions that result in material or moral harm to one of the insurance parties, and which would not have occurred but for how the negligent person who acted.

65. Age calculation: Process by which age is calculated according to the calendar year starting at the beginning of January and ending at the end of December.

66. Personal data protection system: The Personal Data Protection Regulations issued by Royal Decree No. (M/19) dated 9/2/1443 H (16/9/2021)

الثالث من هذه الوثيقة، على أن يصفها طبيب مرخص بسبب علة تعرض لها المؤمن له، شريطة أن تكون تلك النفقات ضرورية ومعقولة ومعتادة في الوقت والمكان الذي تمت فيه بناء على أفضل الممارسات الطبية المعتمدة.

60. المطالبة: طلب مقدم إلى شركة التأمين أو من يمثلها من مقدم خدمة أو المؤمن له أو من حامل الوثيقة، بغرض استعاضة قيمة نفقات الخدمات الصحية المشمولة ضمن تغطية الوثيقة والمشفوع بالمستندات المالية والطبية المؤيدة له.

61. المستندات المؤيدة للمطالبة: جميع المستندات التي تثبت عمر المؤمن ووزنه وطوله له وجنسيته وهويته وسريان التغطية التأمينية وملاسات وقوع الحدث الناشئة عنه تلك المطالبة وما يثبت سداد التكاليف. كما تشمل مستندات أخرى مثل تقرير الشرطة، الفواتير، الإيصالات، الوصفات الطبية، تقرير الطبيب، الإحالة والتوصيات، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى ذات علاقة قد تطلبها شركة التأمين.

62. الاحتيال: قيام أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل بهدف كسب ميزة غير نزيهة أو غير مشروعة لصالح الطرف الذي يرتكب جريمة الاحتيال أو لصالح أطراف أخرى، أو تتطوي على غش أو خداع والذي ينتج عنه الحصول على منافع أو أموال أو تقديم مزاي مستتاة أو تتجاوز الحدود المسموح بها إلى الفرد أو الجهة، وما يدخل تحت ذلك وفقاً للنظام واللائحة التنفيذية.

63. إساءة الاستخدام: قيام أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية بممارسات قد تؤدي إلى الحصول على منافع أو مزاي غير مخولين بالحصول عليها ولكن بدون قصد التدليس والاحتيال أو تعمد الكذب وتشويه الحقائق للحصول على المنفعة وما يدخل تحت ذلك وفقاً للنظام واللائحة التنفيذية، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر - المبالغة في التحاليل التشخيصية والأدوية.

64. الإهمال: تقديم إجراءات تأمينية/طبية بدون توخي مقداراً معقولاً من الحذر المتعارف عليه طبياً، والذي كان سبباً في حدوث ضرر مادي أو معنوي لأحد الأطراف التأمينية والذي لم يكن ليحصل لولا الإهمال الذي تم.

65. احتساب العمر: يحتسب العمر بحسب السنة الميلادية التي تبدأ مع بداية شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر.

66. نظام حماية البيانات الشخصية: نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 09/02/1443هـ (الموافق 16/09/2021).

Section II: Recoverable Expenses / Benefits

For purposes of this policy, recoverable expenses shall mean the actual expenses incurred for services, supplies and equipment, which are not excluded under Chapter Three (3) herein, provided that it shall be prescribed by a licensed physician as a result of an illness suffered by the insured. Said expenses shall be necessary, reasonable and customary in the relevant time and place. Recoverable expenses shall include:

(1) Costs of preparation and repatriation of the insured corpse to the home country specified in the employment contract, if the cause of death shall not be one of the exceptions stipulated in Chapter 3 herein.

(2) Health benefits:

A. Expenses of medical examination, diagnosis, treatment and medicine as shown in the policy schedule.

B. Preventive measures, such as vaccinations including seasonal vaccinations and maternity and childcare, in accordance with the instructions issued by the Ministry of Health, as stipulated in Annex 1 attached to this Policy.

C. Expenses of hospitalization, including surgeries, same-day surgeries or treatment, pregnancy, and delivery.

D. Treatment of all Hereditary Diseases.

E. Disability cases within the limits specified in the Policy Schedule.

F. Medical interventions for long-term care that are life sustaining or affect outcomes with the exception of what have been exempted as stipulated in Chapter 3 herein.

G. Functional vision corrective intervention that prevent vision loss.

H. Medical equipment, and in order to describe the medical equipment systematically by a physician licensed from a certified center, the following must be complied with:

1. The Insured shall have the relevant illness or condition, including heart diseases, hypertension, diabetes, and respiratory diseases.

2. The medical equipment, licensed by the Saudi Food & Drug Authority, shall be provided through the preferred provider network accredited by the Insurance Company, according to the normal and reasonable prices, one time throughout the validity period of the policy, provided that the lifespan of the current equipment that it owns (if any) shall be expired.

النفقات القابلة للاستعاضة / المنافع

لأغراض هذه الوثيقة فإن النفقات القابلة للاستعاضة تعني المصاريف الفعلية المنفقة مقابل خدمات ومواد وأجهزة غير مستتاة بموجب القسم الثالث من هذه الوثيقة، على أن يتم وصفها من قبل مقدم خدمة مرخص بسبب علة تعرض لها المؤمن له شريطة أن تكون تلك النفقات ضرورية ومعقولة ومعتادة في الوقت والمكان الذي تمت فيه، وتشمل النفقات القابلة للاستعاضة كل ما يلي:

(1) مصاريف تجهيز وإعادة جثمان الشخص المؤمن له المتوفى إلى موطنه الأصلي المذكور في عقد العمل، شريطة ألا يكون سبب الوفاة أحد الأسباب المستتاة في القسم الثالث من هذه الوثيقة.

(2) المنافع الصحية، وتشمل كل مما يلي:

أ. جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية، وفقاً لجدول الوثيقة.

ب. الإجراءات الوقائية مثل التطعيمات بما في ذلك التطعيمات الموسمية، ورعاية الأمومة والطفولة وذلك وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة الواردة في الملحق رقم (1) المرفق بهذه الوثيقة.

ج. جميع مصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد والحمل والولادة.

د. علاج كافة الأمراض الوراثية.

هـ. حالات الإعاقة وفق حدود المنفعة المحددة في جدول الوثيقة.

و. التدخلات العلاجية المحافظة على الحياة والتدخلات التي قد تغير النتائج الطبية (Life sustaining and interventions altering medical outcomes) لمستفيدين الرعاية المديدة (رعاية طويلة المدة) ماعدا ما ذكر بالاستثناءات.

ز. إجراءات تصحيح النظر الوظيفي لمنع فقد الإبصار.

ح. الأجهزة الطبية، ووصف الجهاز الطبي بشكل نظامي من قبل طبيب مرخص في مركز معتمد لابد من الالتزام بالآتي:

1. وجود العلة أو المرض لدى المؤمن له، ويشمل ذلك أمراض القلب، الضغط السكري، أمراض الجهاز التنفسي.

2. تصرف الأجهزة الطبية الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين لدى شركة التأمين حسب الأسعار المعتادة والمعقولة مرة واحدة خلال مدة سريان الوثيقة، على أنه يمكن صرف الجهاز مرة أخرى بشرط انتهاء العمر الزمني للجهاز الحالي الذي يملكه -إن وجد.

3. يلزم وجود مبرر طبي -خلال فترة سريان الوثيقة- يستدعي استبدال الجهاز الحالي في حال طلب المؤمن له

3.If the Insured requests a new medical equipment, there shall be a medical reason - during the effective period of the Policy - necessitating replacement of the current equipment. In addition, the Insurance Company may ask for the old equipment so that it can be replaced.
4.The best medical practices shall be referred to and shall be linked to the principle of value-based health care when approving the insurance coverage. In addition, it shall be advised to consult the impact value study published by the international and local health technology assessment centers, if available.
I.Health benefits shall also include all the benefits stated in the schedule provided in Schedule (1) herein.

لجهاز طبي جديد، كما يمكن لشركة التأمين طلب الجهاز القديم من أجل استبداله.
4.يتم الرجوع لأفضل الممارسات الطبية مع ربطها بمبدأ الرعاية الحكيمة المبينة على القيمة عند اعتماد التغطية التأمينية والاعتماد على دراسة قيمة الأثر المعلنة من قبل مراكز تقييم التقنيات الصحية المحلية أو الدولية في حال توفرها.
ط.كما تشمل أيضا كل من المنافع المذكورة بالجدول رقم (1) الوارد لهذه الوثيقة في الجدول.

Section III: Limitations and Exclusions

التحديدات والاستثناءات

(A)This policy will not cover claims resulting from
1.Complications from self-inflicted injury, excluding the costs of treating emergency cases (life-threatening injuries) as described by the Private Health Institutions Law and Regulations approved by the Ministry of Health, which determines how to dispatch emergency cases.
2.Complications from diseases resulting from the intentional abuse of some medications, stimulants, sedatives, substance abuse, etc., excluding the costs of treating emergency cases (life-threatening injuries) as described by the Private Health Institutions Law and Regulations approved by the Ministry of Health, which determines how to dispatch emergency cases.
3.Non re-constructive cosmetic surgeries.
4.General examinations, vaccines, drugs or preventive measures that do not require medical treatment or are not mentioned in this Policy (except for the preventive measures stipulated in the Policy or determined by the Ministry of Health, such as vaccinations as well as maternity and childcare).
5.Treatment received by the insured free of charge.
6.Recreational therapy, general physical health programs, and treatment in social welfare institutions.
7.Any illness or injury arising directly from the profession of the Insured.
8.All costs related to dental implants, dentures, crowns, bridges or cosmetic procedures including, but not limited to, teeth whitening, except for the benefits outlined herein.
9.Vision correction surgeries, excluding procedures that prevent vision loss.
10.The expenses of the transportation of the insured within and between cities in the Kingdom by means of transportation other than the licensed ground ambulance.
11.Hair loss, baldness or artificial hair.
12.Allergy tests of any nature, excluding those related to the medical cases that can only be treated through these tests, or those related to prescribed medications, according to the medical proof and evidence.
13.Equipment, treatments, drugs and hormone procedures, surgeries or treatment aimed at regulating reproduction, contraception, impotence, infertility, in-vitro fertilization, or any other method of artificial fertilization.
14.Any congenital weakness or deformity, unless it has a current or future life-threatening impact on the Insured.
15.Any additional costs or expenses incurred by the companion of the Insured during its stay at the hospital, except for hospital accommodation charges for one companion, as required by the best medical practices.
16.Treatment of acne.
17.Cases of human organ transplantation, according to the definition set out in the First Chapter of the Policy, excluding the additional benefits regarding organ transplantation. Knowing that artificial organs are managed as per the benefits and exceptions of the policy.
18.Joint replacement with exception to what have been listed as benefits or for the treatment of complications arising from a covered benefit such as joint replacement due to cancer or a trauma.
19.Personal risks set forth in Chapter 1 (Definitions) herein. Any sport other than what is mentioned in the definition chapter, must be submitted to the IA for decision.
20.Alternative medicine procedures and medications.
21.Artificial and ancillary limbs.
22.Diseases that are classified by the Ministry of Health as pandemics or natural disasters, and based on decision released by the Insurance Authority.
23.Eye glasses for persons over fourteen (14) years old.
24.Complications resulting from any previous illness or injury shall be excluded under the provisions of this Policy.
25.Long-term care (Care for a long period) that are limited to nursing care or personal care with exception to the benefits listed in this policy.
26.Rehabilitation admissions for management of addiction and alcohol abuse
(B)Except for the provisions of Section 2 herein, this policy shall not cover health benefits or corpse repatriation to home country in claims resulting from the following:
1.War, invasion, acts of (foreign) aggression whether or not war is declared.
2.Ionizing radiations and pollution from radioactive activity of any nuclear fuel or waste resulting from the combustion of nuclear fuel.
3.Radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any nuclear plant or any of its nuclear components.
4.The Insured service or participation in armed forces or police operations.
5.Riots, strike, terrorism, or its equivalents.
6.Accidents or chemical, biological, or bacteriological reaction, if those accidents or reactions are a result of occupational injury or occupational risk.
(c)Hotels, dormitories, guest houses, resorts, convalescent centers, sanatoriums, places for the care of persons in custody, nursing home, or schools/institutes specialized in teaching deaf, autistic, etc. shall not be included under the concept of the Hospital described in this Policy.

The above stated exclusions are standard exclusions which are stated in the IA policy wording and hence, any additional covers/benefits stated in the policy table of benefits should be considered as covered benefit.

(أ) لا تغطي هذه الوثيقة المطالبات الناشئة مباشرة عن الآتي:
1. مضاعفات الإصابة التي يسببها الشخص لنفسه متعمدا باستثناء تكاليف علاج الإصابات للحالات الطارئة.
2. مضاعفات الأمراض التي تنشأ بفعل إساءة الاستعمال المتعمد لبعض الأدوية أو المنشطات أو المهذات أو بفعل تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات أو ما شابه ذلك باستثناء تكاليف علاج الإصابات للحالات الطارئة.
3. الجراحة التجميلية غير الترميمية.
4. الفحوصات الشاملة واللقاحات أو العقاقير أو الوسائل الوقائية التي لا تتطلب علاج طبي أو لم يتم النص عليها في هذه الوثيقة (باستثناء الإجراءات الوقائية المذكورة بالوثيقة أو التي تحددها وزارة الصحة مثل التطعيمات ورعاية الأمومة والطفولة).
5. المعالجة التي يتلقاها الشخص المؤمن له بدون مقابل.
6. الاستجمام وبرامج الصحة البدنية العامة والعلاج في دور الرعاية الاجتماعية.
7. أي علة أو إصابة تنشأ كنتيجة مباشرة لمهنة الشخص المؤمن له.
8. جميع التكاليف المتعلقة بزرع الأسنان أو تركيب الأسنان الاصطناعية، تقويم الأسنان، أطقم الأسنان، التيجان، الجسور أو الإجراء التجميلي على سبيل المثال لا الحصر تبيض الأسنان باستثناء ما ذكر من منافع بالوثيقة.
9. إجراءات تصحيح النظر لأمراض العين التي لا تؤدي لفقد البصر.
10. مصاريف انتقال الشخص المؤمن له داخل وبين مدن المملكة بوسائل نقل غير الإسعاف الأرضي المرخص.
11. تساقط الشعر أو الصلع أو الشعر المستعار.
12. اختبارات الحساسية مهما كانت طبيعتها، فيما عدا تلك الحالات غير الممكن علاجها بدون إجراء هذه الاختبارات، أو الحالات المتعلقة بوصف أدوية العلاج حسب الأدلة والبراهين الطبية.
13. الأجهزة والوسائل والعقاقير والإجراءات أو الجراحات أو المعالجة بالهرمونات بهدف حصول حمل أو علاج العقم أو العجز الجنسي أو نقص الخصوية أو التخصب بواسطة الأنابيب أو أي وسائل أخرى للتلقيح الاصطناعي.
14. حالات التشوه الخلقي، باستثناء الحالات التي تشكل تهديد حالي أو مستقبلي على حياة المؤمن له.
15. أي تكاليف أو مصاريف إضافية يتكبدها المرافق للمؤمن له أثناء توبيمه أو إقامته بالمستشفى، عدا نفقة الإقامة والإعاشة في المستشفى لمرافق واحد للمؤمن له، وحيثما تقتضي أفضل الممارسات الطبية المعتبرة.
16. معالجة حب الشباب .
17. حالات زراعة الأعضاء البشرية بحسب التعريف الوارد في القسم الأول من الوثيقة، ويستثنى من ذلك ما تم إضافته للمنافع بخصوص زراعة الأعضاء. علما بأن الأعضاء الصناعية تعامل بحسب منافع واستثناءات الوثيقة.
18. استبدال المفصل ماعدا ما ذكر من منافع بالوثيقة أو لعلاج المضاعفات الناتجة عن منفعة مقطوعة مثل استبدال مفصل الركبة بسب سرطان أو حادث.
19. الأخطار الشخصية الواردة في قسم التعريفات من هذه الوثيقة إضافة أي رياضة غير مذكر بقسم التعريفات ترفع للهيئة للبت فيها.
20. أدوية ووسائل العلاج بالطب البديل.
21. الأطراف الصناعية والأطراف المساعدة.
22. الأمراض التي يتم تصنيفها بواسطة وزارة الصحة كالأوبئة، الجوائح، والكوارث الطبيعية و يصدر بها قرار من هيئة التأمين.
23. النظارات الطبية لمتجاوز الأربعة عشر (14) عاما.
24. المضاعفات الناتجة عن أي مرض أو إصابة سابقة مستثناة بموجب أحكام هذه الوثيقة.
25. الرعاية المديدة (رعاية طويلة المدة) المقصورة على الرعاية التمرضية والعناية الشخصية ماعدا ما ذكر من المنافع.
26. التنويم للعلاج التاهل لتعاطي الكحول أو المخدرات.
(ب) استثناء من أحكام القسم الثاني من هذه الوثيقة، لن يتم تغطية المنافع الصحية أو إعادة الجثمان إلى الوطن الأصلي في حالة المطالبات الناشئة عن الآتي:
1. الحرب، الغزو، أعمال العدوان (الأجنبي) سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن.
2. الإشعاعات الأيونية أو التلوث بالنشاط الإشعاعي من أي وقود نووي أو أي نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي.
3. الخصائص المشعة أو السامة أو المتفجرة أو أي خصائص خطيرة أخرى لأي تجمعات نووية أو لأي من مركباتها النووية.
4. مزاوله الشخص المؤمن له أو مشاركته في خدمة القوات المسلحة أو الشرطة أو عملياتها.
5. أعمال الشغب، أو الإضراب، أو الإرهاب أو ما يشابهها من أعمال .
6. الحوادث أو التفاعلات الكيميائية أو البيولوجية أو البكتريولوجية، إذا كانت هذه الحوادث أو التفاعلات ناتجة عن إصابات عمل أو بسبب مخاطر مهنية.
(ج) لا يندرج تحت مفهوم المستشفى في هذه الوثيقة كل من الفنادق ، أو دور النماة، أو دور الضيافة، أو الاستراحات، أو دور النقاة، أو المصحات، أو أماكن رعاية الأشخاص المحتفظ عليهم، أو ماوي كبار السن أو المدارس/المعاهد المتخصصة بتعليم الصم والبكم والتوحد، وما شابههم.

الاستثناءات المشار إليها أعلاه هي استثناءات أساسية مذكورة في وثيقة هيئة التأمين ولذلك أي مزاي / تغطيات مشار إليها في جدول منافع الوثيقة سوف تعتبر مزاي مغطاه.

Section IV : General Conditions

الشروط العامة

(1)Proof of Validity:
This policy represents the basic level of insurance cover granted to the insured individual. This Policy shall not be valid unless confirmed by a schedule duly signed by

(1) اثبات سريان المفعول:
تمثل هذه الوثيقة الحد الأساسي من التغطية التأمينية المقدمة للأشخاص المؤمن لهم. ولن تكون هذه الوثيقة سارية المفعول ما لم يثبت ذلك بجدول موقع عليه من موظف مخول رسميا من شركة التأمين، كما ولن يسري مفعول أي

an employee officially authorized by the Company. Likewise, any addition to this policy shall not be valid unless confirmed and accompanied with signed annex by an officially authorized assigned employee of the insurance company.

(2) Effective Dates of Coverage:

A. For Workers: Coverage shall become effective for the active employee as of the inception date shown in the Policy schedule, or from the date of employment contract for the workers joining work in a later time.

B. For Dependents: Insurance cover shall become effective for dependents as of the date, during which the worker supporting them becomes insured or from the date they become dependents.

C. For Fetus and Newborn infants:

1. The insurance coverage for fetuses shall begin from the beginning of their inception until one month after birth, and its coverage shall be according to the limit of the Policy.

2. Insurance coverage for newborn infants shall enter into effect immediately after delivery to a maximum of 30 days from the date of delivery, and its coverage shall be according to the limit of the mother policy.

(3) Termination of the Insurance Coverage of the Insured Individuals:

A. For Workers: Coverage of any worker under the Policy shall be automatically terminated in the following cases:

1. If the Policy period ends or if it is canceled, as stipulated in the Policy Schedule.

2. Upon the exhaustion of the maximum limit of benefits stipulated in the Policy.

3. If the Insured dies, without prejudice to paragraph (1) of Chapter 2 herein and as per the benefits limits in Policy Schedule.

4. If the Insured leaves the Kingdom permanently.

5. If the Insured transfers to a new employer.

B. For Dependents: coverage under this Policy shall be automatically terminated in the following cases:

1. The dependent no longer qualifies as "dependent" as defined in Chapter 1 herein.

2. If the Policy period ends as specified in the schedule.

3. Upon the exhaustion of the maximum limit of benefits provided for in the Policy.

4. If the Insured dies, without prejudice to paragraph (1) of Chapter 2 herein under the benefits limits stipulated in the Policy Schedule.

5. If the Insured leaves the Kingdom permanently.

6. If the Insured transfers to a new employer.

(C) Payment of recoverable expenses of any current illness, which requires continued hospitalization, shall continue on the date of termination of coverage for the period necessary for treating such illness, provided that such period shall not exceed 365 days as of the date of onset of said illness and within the limits of the maximum coverage amount stipulated in the Policy Schedule.

(4) Payment of Premiums (subscriptions):

A. The Policyholder shall pay the health insurance premium due on each insured individual as agreed upon with the Company as of the effective date of the insurance coverage.

B. If any portion of a premium is not paid, the Policy shall not be valid for a period longer than that covered by the portion paid, and the Company shall notify the IA accordingly.

(5) Cancellation:

The Policyholder may cancel this Policy at any time under a written notice sent to the Company within a minimum of 30 business days prior to the date required for cancellation, taking into account the rules governing forming and managing insurance risk pools. In such case, the Policyholder and the Insurance Company shall comply with the following:

A. The Insurance Company shall inform (under an official notice) the IA and the Preferred Provider Network once it receives a notice from the Policyholder - employer or the Insured - with regard to the Cancellation of the Policy.

B. In the event of transferring the employment contract, the Employer shall execute another insurance policy with a qualified company, or the Employer shall include the insured individuals in a health coverage under another insurance coverage program approved by the IA. The new insurance coverage shall start as of the day following the cancellation of the previous policy.

C. The Employer may remove one or more employees from the Policy, after the Insurance Company receives proof that the Insured has left the Kingdom or transferred to a new employer.

D. In the event of the cancellation of a Policy or removal/ deletion of an Insured, the Company shall ensure updating the data of the developed policy issuance system, according to the codes of cancellation or deletion.

In such case, the Company shall be liable to provide the Policyholder, within 60 business days from the cancellation date, with the remaining part of the premium for each insured individual whose claims did not exceed 75% of the annual premium. The refundable amount shall be calculated on proportional basis: (Refund = annual premium ÷ 365.25 days X the number of the remaining days)

E. If the Policyholder refrains from paying the Company the expense exceeding the maximum limit of benefit within the period specified in Article (11) (Basis of Direct Debiting on the Company Account for the Service Provider Network) of the General Conditions of the Policy and due as a result of the arrangement for direct billing of the Company, the Company has the right to withhold refund of premiums, if any, and use such amounts to compensate for the expenses paid to the service providers which should have been paid to the Company by the Policyholder.

F. The Policyholder shall pay all expenses due to the Insurance Company within the specified period, and if such period expires, the Insurance Company has the right to refer to SIMAH as well as to the Insurance Company, in case the beneficiary is entitled to the benefit.

(6) Records and Reports:

The Policyholder must maintain a record for all of its employees and their insured dependents. This record shall include the individual's full name, sex, age, nationality, weight, height, classification and other basic information that might affect the management of this health insurance and the report on the premium rates. The insurance company shall be given access to such records to verify the accuracy of the information provided by the Policyholder, whenever needed. The Company shall, when requested, provide the Policyholder with any information about the Insured, in a manner consistent with the provisions of Personal Data Protection Law.

(7) Adding and Deleting the Insureds and Related Contributions:

A. The Policyholder shall immediately and officially notify the Company regarding all workers or dependents to be covered under the Health Insurance at the Policy effective

إضافة عليها إلا إذا أثبت ذلك بموجب ملحق موقع من موظف محول رسمياً من شركة التأمين.

(2) تواريخ سريان التغطية التأمينية:

(أ) بالنسبة للعاملين: يبدأ سريان التغطية التأمينية بالنسبة للعامل الموجود فعلياً على رأس العمل اعتباراً من تاريخ الابتداء المحدد في جدول الوثيقة، أو من تاريخ عقد العمل بالنسبة للعامل الذي يلتحق بالعمل في وقت لاحق.

(ب) بالنسبة للعاملين: يبدأ سريان التغطية التأمينية بالنسبة للعاملين من التاريخ الذي أصبح فيه العامل والمسؤول عن إعالتهم مؤمناً له أو في التاريخ الذي اكتسبوا فيه لأول مرة صفة معالين.

(ت) بالنسبة للأنجبة والأطفال حديثي الولادة:

1. يبدأ سريان التغطية التأمينية بالنسبة للأنجبة من بداية تكوينه إلى بعد الولادة بشهر، وتكون تغطيته بحسب حد الوثيقة.

2. يبدأ سريان التغطية التأمينية بالنسبة للأطفال حديثي الولادة من الولادة على وثيقة الأم ويحد أقصى 30 يوم من تاريخ الولادة حتى يتم إضافتهم على الوثيقة بأثر رجعي من تاريخ الولادة. وتكون تغطيته بحسب حد الوثيقة.

(3) انتهاء التغطية التأمينية للمؤمن لهم:

(أ) بالنسبة للعاملين: تنتهي تلقائياً تغطية العامل التأمينية بموجب هذه الوثيقة في الحالات التالية:

1. إذا انتهت مدة الوثيقة أو في حال تم إلغائها على النحو المحدد في جدول الوثيقة.

2. عند استنفاد الحد الأقصى للمنفعة المنصوص عليه في الوثيقة.

3. عند وفاة المؤمن له، وذلك مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (1) من القسم الثاني من هذه الوثيقة وبموجب حدود المنفعة في جدول الوثيقة.

4. عند مفارقة المؤمن له المملكة نهائياً.

5. عند انتقال المؤمن له للعمل لدى صاحب عمل جديد.

(ب) بالنسبة للعاملين: تنتهي تلقائياً تغطية المعال التأمينية بموجب هذه الوثيقة في الحالات التالية:

1. فقدان المعال لصفته التأمينية كعالم وفقاً لتعريف الوارد في القسم الأول من الوثيقة.

2. إذا انتهت مدة الوثيقة كما هي محددة في جدول الوثيقة.

3. عند استنفاد الحد الأقصى للمنفعة المنصوص عليه في الوثيقة.

4. عند وفاة المؤمن له، وذلك مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (1) من القسم الثاني من هذه الوثيقة وبموجب حدود المنفعة في جدول الوثيقة.

5. عند مفارقة المؤمن له النهائي من المملكة.

6. عند انتقال المؤمن له للعمل لدى صاحب عمل جديد.

(ت) يستمر أداء النفقات القابلة للاستعاضة بالنسبة لأي علة جارية أدت إلى استمرار التنويم بالمستشفى في تاريخ انتهاء التغطية التأمينية وذلك للمدة التي تتطلبها العلة شريطة ألا تتجاوز تلك المدة 365 يوماً تحسب من تاريخ ابتداء العلة التي استدعت التنويم بالمستشفى وفي حدود الحد الأقصى للتغطية الواردة في جدول الوثيقة.

(4) سداد القسط (الاشتراك):

(أ) يلتزم حامل الوثيقة بسداد اشتراك/قسط التأمين الصحي المتفق عليه مع شركة التأمين الواجب أدائه عن كل شخص مؤمن له، وذلك من تاريخ سريان التغطية التأمينية.

(ب) في حالة عدم سداد أي جزء من الاشتراك فإن الوثيقة لن تبقى سارية المفعول لمدة أطول من المدة التي يغطيها الجزء المسدد من الاشتراك، مع التزام شركة التأمين بإبلاغ الهيئة بذلك.

(5) الإلغاء:

يجوز لحامل الوثيقة إلغاء الوثيقة في أي وقت، بموجب إشعار رسمي يرسل لشركة التأمين قبل (30) يوم عمل على الأقل من تاريخ الإلغاء المطلوب، مع الأخذ بالاعتبار ما ورد في ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي والضوابط والتعليمات المنظمة، ويلتزم كل من حامل الوثيقة وشركة التأمين في هذه الحالة بالتالي:

(أ) تقوم شركة التأمين بإبلاغ (بموجب إشعار رسمي) الهيئة وشبكة مقدمي الخدمة فور تلقيها إشعار حامل الوثيقة صاحب العمل أو المؤمن له - بإلغاء الوثيقة.

(ب) في حالة نقل عقد التأمين، يلتزم صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين أخرى مع شركة مؤهلة، أو يقوم صاحب العمل بتضمين المؤمن لهم بتغطية صحية بموجب برنامج تغطية تأمينية آخر مقبول من الهيئة بحيث تبدأ التغطية التأمينية الجديدة من تاريخ اليوم التالي لإلغاء الوثيقة السابقة.

(ت) يجوز لصاحب العمل شطب عامل أو أكثر من الوثيقة، وذلك بعد التقديم إلى شركة التأمين ما يثبت مفارقة المؤمن له من المملكة أو انتقاله إلى صاحب عمل جديد.

(ث) عند إلغاء وثيقة أو شطب/حذف المؤمن له، يلتزم شركة التأمين بالتأكد من تحديث بيانات نظام إصدار الوثائق المطور وذلك حسب الرموز الخاصة بعملية الإلغاء أو الحذف.

وفي هذه الحالة تكون شركة التأمين ملزمة خلال مدة لا تزيد عن (60) يوم عمل من تاريخ الإلغاء بأن تعيد لحامل الوثيقة الجزء المتبقى من الاشتراك عن كل شخص مؤمن له لم تتجاوز مطالباته 75 % من قيمة الاشتراك السنوي بحيث يتم احتساب الجزء المعاد من الاشتراك على أساس تناسبي: (الجزء المعاد = الاشتراك السنوي ÷ 365.25 يوماً * عدد الأيام المتبقية).

(ج) حالة امتناع حامل الوثيقة عن رد النفقات التي جاوزت حد المنفعة الأقصى خلال المدة المحددة في المادة رقم (11) (أساس التقييم المباشر على حساب شركة التأمين لدى شبكة مقدمي الخدمة) من الشروط العامة للوثيقة المترتبة نتيجة أسلوب التقييم المباشر على حساب شركة التأمين، يحق لشركة التأمين الامتناع عن رد الاشتراكات القابلة للإعادة (إن وجدت) واستخدامها للتعويض عن النفقات المدفوعة لمقدمي الخدمة والتي كان يتوجب على حامل الوثيقة أدائها لشركة التأمين.

(ح) يلتزم حامل الوثيقة بسداد كافة المصاريف المستحقة لشركة التأمين خلال المدة المحددة لذلك، وفي حال انتهاء المدة المحددة قبل إتمام السداد، يحق لشركة التأمين الرفع لسمه بالإضافة للرفع لصندوق الضمان في حال أحقية المستفيد للمنفعة.

(6) السجلات والتقارير:

على حامل الوثيقة أن يحتفظ بسجل لجميع العاملين لديه ومعاليلهم المؤمن لهم بموجب هذه الوثيقة، على أن يحتوي هذا السجل بالنسبة لكل شخص على الاسم الكامل والجنس والعمر والجنسية والوزن والطول والتصنيف وغير ذلك من المعلومات الأساسية التي يمكن أن يكون لها تأثير على إدارة هذا التأمين الصحي وعلى التقرير بشأن معدلات الاشتراك. ويتوجب إتاحة الفرصة لشركة التأمين متى ما رغب في ذلك - للاطلاع على هذه السجلات والتأكد من صحة المعلومات التي قدمها حامل الوثيقة، ولتزام شركة التأمين متى ما طلب منها ذلك بتزويد حامل الوثيقة بأي بيانات قد يرغب الإطلاع عليها بشأن الأشخاص المؤمن لهم بما لا يتعارض مع أحكام نظام حماية البيانات الشخصية إضافة إلى الالتزام بكافة الأنظمة ذات العلاقة الأخرى.

(7) إضافة وحذف الأشخاص المؤمن لهم و الاشتراكات المتعلقة بذلك:

(أ) على حامل الوثيقة أن يخطر فوراً وبصفة رسمية شركة التأمين على كافة العاملين أو المعالين الواجب نظاماً تغطيتهم بالتأمين الصحي عند بداية سريان الوثيقة، ويحق له إضافة مؤمن له على أساس تناسبي في حال وجود ما يثبت انضمام العامل للعمل لدى صاحب العمل أو طلب حذفه حال انتقاله إلى العمل لدى صاحب عمل آخر.

(ب) بالنسبة للإضافات التي لا ينطبق عليها ما ورد في الفقرة (أ) أعلاه، فإن إضافة أعداد المستجدين من المؤمن لهم يتم من تاريخ إصدار الوثيقة وتكون تغطيته / تغطيتهم سارية من تاريخ الإضافة.

(8) المؤهلون للتأمين:

(أ) بالنسبة للعاملين: فإن أي شخص مستوف لتعريف العامل يكون مؤهلاً للتأمين وفقاً لما نص عليه جدول الوثيقة.

(ب) بالنسبة للعاملين: فإن أي شخص مستوف لتعريف المعال يكون مؤهلاً للتأمين وفقاً لما نص عليه جدول الوثيقة.

(9) الأدوار الجاهزة بالتغطية التأمينية:

إذا كان أي شخص معرف كمعال؛ بالإضافة إلى كونه مؤهل للتأمين بصفته عاملاً، فإن تمتعه بالتأمين الصحي بصفته معالاً سوف يتوقف بمقتضى هذه الوثيقة. وعندما يكون كل من الزوج أو الزوجة مقيمين معاً إقامة دائمة ويتعاملان بالتغطية التأمينية بوصفهما عاملين، فيصبح الأولاد في هذه الحالة مؤهلين فقط كمعالين من قبل الزوج، إلا في حال رغب صاحب المعال بإضافة المعالين -الأولاد- ضمن التغطية التأمينية، على ألا يكون هناك مستفيد يتمتع بتغطيتين تأمينيتين مختلفتين خلال الفترة ذاتها إلا من خلال تغطيات إضافية أو تكميلية.

date. The policyholder has the right to add an Insured on a proportional basis if there is a proof that the Employee joined the work for the employer, or requested deleting it in case it moved to work for another employer.

B.For additions, to which what is mentioned in paragraph (A) here above does not apply, the addition of the numbers of new Insureds shall be effective as of the date of issuing the Policy, and its/their coverage shall be valid from the date of addition.

(8)Eligibility:

A.For Workers: Any person satisfying the definition of "Worker" shall be qualified for insurance in accordance with the Policy Schedule.

B.For Dependents: Any person satisfying the definition of "Dependent" shall be eligible for insurance in accordance with the Policy Schedule.

(9)Duplication of Insurance Coverage:

If any person is identified as Dependent, in addition to being eligible for insurance as a worker, its health insurance as dependent will cease hereunder. When the husband and wife permanently reside together and have insurance as workers, the children in this case shall become eligible only as dependents of the husband, unless the employer wishes to add dependents - children - within the insurance coverage of the wife, provided that there shall be no Beneficiary who has two different insurance coverages during the same period.

(10)Non-Duplication of Benefits:

If there is a claim for recoverable expenses due under this Policy to the Insured, and these expenses are covered under another insurance, plan, program, etc., the Company shall then be responsible for paying such expenses and request the third parties to pay their proportional shares of such claim on behalf of the Insured.

(11)Basis of the direct entry or in company's account at the Service Providers' Network:

A.The service providers appointed by the Insurance Company shall send all medical expenses incurred hereunder, on a monthly basis and without prejudice to the days and periods specified in the document cycle in accordance with Article No. (90) of the Implementing Regulations. The Company shall evaluate and process such expenses, and notify the Policyholder when the expenses reach the maximum benefit limit, provided that the Company shall provide all information related to the remaining insurance limit for benefits and the Policy to the service provider before notifying that the expenses has reached the maximum benefit limit.

B.If this limit is exceeded and the Company has already incurred it, it becomes entitled to claim for the refund of such expenses within a period not exceeding (60) business days from the date of informing the Policyholder of these expenses.

C.If the Policyholder fails to comply with the reimbursement of such expenses to the Insurance Company within the specified period, it becomes entitled to refer to the IA to take the necessary action.

D.The Insurance Company has the right to refer to SIMAH if the Policyholder fails to pay the expenses due to the Insurance Company within the specified period, as well as to the Insurance Fund, if the beneficiary is entitled to the benefit.

(12)Canceling a Service Provider from the Preferred Service Providers Network

A. After issuing the Policy to the Employer, the Company is not entitled to delete or replace a health service provider from the Preferred Provider Network during the Insurance Period, except in the following cases:

1.If the health service provider has committed a fundamental breach of service provision, such as negligence or fraud.

2.Upon termination of the Contract by the health service provider, provided that the Company shall provide a substitute for it at the same level in coordination with the Policyholder.

3.Upon suspension/cancellation of its approval by the IA, provided that the Insurance Company shall provide a substitute for it at the same level in coordination with the Policyholder.

In all cases, the specified warning period and the cancellation conditions stipulated in the contract between the Insurance Company and the health service provider shall be observed. If a service provider is removed from the minimum network, it will continue to receive previously approved applicable policies until their expiry date. Insurance Company shall notify the IA when moving a service provider from an insurance category to another.

(13)User charges (Copayment):

A.Based on an agreement between the Policyholder and the Insurance Company, the deductible amount shall not exceed the amount specified herein. It shall be a binding and an obligatory condition for the Insured to pay the user charges amount (if any) as specified according to the contract concluded between the Policyholder and the Insurance Company. Any attempt by the Insured to refrain from the payment shall be considered a violation of the Policy provisions and its terms and conditions. It shall become invalid for it until the payment of this amount.

B.Cases of emergency and inpatient admission shall be excluded from Paragraph (A).

C.The copayment amount charged to the Beneficiary shall not exceed what is specified in the Schedule of Health Benefits contained in Appendix No. (1).

D.The amount of deductible or copayment for the outpatient clinics shall be separated from the service of dispensing medicines for one visit.

E.The maximum deductible amount for medicines shall be calculated based on the price of the generic medicine or the brand Innovative medicine in the absence of a generic medicine registered with the Saudi Food & Drug Authority.

F.The difference between the value of the generic medicine and the innovative medicine shall be paid in full by the Beneficiary if there is a registered generic medication alternative. The price difference shall not be included in the maximum deductible amount.

G.Service provider must prescribe medical devices on the scientific name basset without specification of a trade name.

H.An automatic substitution of the device name shall be done based on the beneficiary policy with accounting for the following exceptions:

a.if the healthcare provider requested no substitution with the following considerations:

i.To rely on a reasonable medical justification and attach documents justifying the application for approval by the Insurance Company, in case of obtaining the approval of the Company.

ii.If the Insurance Company deems that the medical justification is not possible, the beneficiary's shall pay the difference between the price of the two devices.

b.If the beneficiary request dispensation of the medical devices as per the requested name, the beneficiary shall pay the difference between the price of the two devices.

I.The amount of deductible must be clarified to the Beneficiary in details before providing the service based on the Policy.

(10) عدم ازدواجية المنافع:

في حالة المطالبة عن نفقات قابلة للاستعاضة وقابلة للأداء للمؤمن له بموجب هذه الوثيقة، ويكون مقبلي أيضاً، بالنسبة لتلك النفقات، بموجب أي خطة أو برنامج أو تأمين آخر أو ما شابه ذلك، ففي هذه الحالة تكون شركة التأمين مسؤولة عن تغطية تلك النفقات، وتحتل محل المؤمن له في مطالبة الغير بدفع حصته من النسبة من تلك المطالبة.

(11) أساس التقييد المباشر على حساب شركة التأمين لدى شبكة مقدمي الخدمة:

(أ) يرسل مقدمي الخدمة المعنيين من شركة التأمين، وعلى أساس شهري دون الإخلال بالأيام والمدة المحددة بالدورة المستندية وفقاً لما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية، جميع النفقات الطبية المتكبدة بموجب هذه الوثيقة. وتقوم شركة التأمين بتقييم تلك النفقات ومعالجتها، وإشعار حامل الوثيقة عند بلوغ النفقات حد المنفعة الأقصى على أن تقوم شركة التأمين بتوفير جميع المعلومات المتعلقة بالحد التأميني المتبقي للمنافع والوثيقة لمقدم الخدمة قبل الإشعار ببلوغ النفقات حد المنفعة الأقصى.

(ب) في حالة تجاوز ذلك الحد وتكون شركة التأمين قد تحملته بالفعل، فيحق لها المطالبة برد تلك النفقات خلال مدة لا تزيد عن (60) يوم عمل من تاريخ إبلاغ حامل الوثيقة بهذه النفقات.

(ت) في حالة عدم تقييد حامل الوثيقة برد تلك المصاريف لشركة التأمين خلال المدة المحددة، يحق لشركة التأمين الرفع للهيئة لاتخاذ ما يلزم.

(ث) يحق لشركة التأمين الرفع لسمة في حال عدم سداد حامل الوثيقة للمصاريف المستحقة لشركة التأمين خلال المدة المحددة، بالإضافة للرفع إلى صندوق الضمان في حال أحقية المستفيد للمنفعة.

(12) إلغاء مقدم خدمة من شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة:

(أ) لا يحق لشركة التأمين بعد إصدار الوثيقة لصاحب العمل حذف أو استبدال مقدم خدمة صحية من شبكة مقدمي الخدمة المستعمدة المحددة له خلال فترة سريان الوثيقة إلا في الحالات التالية:

1. إذا وقع من قبل مقدم الخدمة الصحية إخلالاً جوهرياً بتقديم الخدمة كالأهمل أو الإهمال أو الاحتيال.

2. عند انتهاء التعاقد من قبل مقدم الخدمة الصحية، على أن تقوم شركة التأمين بتوفير بديل عنه بنفس المستوى بالتنسيق مع حامل الوثيقة.

3. عند تعليق/الإلغاء اعتماده من قبل الهيئة، على أن تقوم شركة التأمين بتوفير بديل عنه بنفس المستوى والمنطقة بالتنسيق مع حامل الوثيقة.

وفي جميع الحالات، يجب مراعاة مهلة الإذراء المحددة وشروط الإلغاء المنصوص عليها في العقد المبرم بين شركة التأمين ومقدم الخدمة الصحية، وفي حال حذف مقدم خدمة من شبكة الحد الأدنى فإنه يستمر في استقبال الوثائق السارية المعتمدة في السابق وحتى تاريخ انتهائها. وتلتزم شركات التأمين بإخطار الهيئة عند استبدال مقدم خدمة من فئة تأمينية إلى أخرى.

(13) نسبة التحمل والمشاركة في الدفع:

(أ) بناء على الاتفاق بين حامل الوثيقة وشركة التأمين، يجب ألا تتجاوز نسبة التحمل المبلغ المحدد في هذه الوثيقة، ويعد شرط ملزم وإجباري قيام المؤمن له بدفع مبلغ نسبة التحمل (إن وجد) المحددة بحسب العقد المبرم بين حامل الوثيقة وشركة التأمين، وتعد أي محاولة من جانب المؤمن له للإمتناع عن الدفع إخلالاً بأحكام الوثيقة وشروطها وببطل مفعولها بالنسبة له لحين سداد هذا المبلغ.

(ب) يستثنى من الفقرة (أ) حالات الطوارئ والتأمين.

(ت) يجب ألا يتجاوز مبلغ المشاركة في الدفع المحملة للمستفيد ما هو محدد بجدول منافع الصحة الوارد في الملحق رقم (1).

(ث) تفصل نسبة التحمل أو المشاركة في الدفع للعيادات الخارجية عن خدمة صرف الأدوية للزيارة الواحدة. يحتسب الحد الأقصى لنسبة التحمل للأدوية بناء على سعر العلاج الجيني أو العلاج المبكر في حال عدم وجود علاج جيني مسجل بهيئة الغذاء والدواء.

(ج) يتم دفع الفرق بين قيمة العلاج الجيني والعلاج المبكر كاملاً من قبل المستفيد في حال وجود علاج جيني مسجل، ولا يضمن فرق السعر بأحد الأقصى لنسبة التحمل.

(خ) يلتزم مقدم الخدمة بوصف الجهاز الطبي بالاسم العلمي وعدم تحديد علامة تجارية بعينها.

(د) سيتم إجراء استبدال ثلثاني لاسم الجهاز الطبي إذا تم وصفه باسم علامة تجارية مستنداً إلى وثيقة المؤمن له، مع مراعاة الاستثناءات التالية:

أ. إذا تم الطلب من قبل الطبيب المعالج بعدم استبدال الاسم التجاري للجهاز الطبي، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة:

1. الاستناد على مبرر طبي مقبول وارفاق المستندات المبررة للطلب لأخذ موافقة شركة التأمين، في حال عدم ممانعتها.

2. في حال كان المبرر الطبي غير مقبول من قبل شركة التأمين، يتم إلزام المؤمن له بدفع قيمة الفارق بين سعر الجهازين بعد إبلاغه بوجود البديل الأرخص.

ب. إذا طلب المؤمن له صرف الجهاز الطبي الموصوف له باسم تجاري محدد يتم إلزام المؤمن له بدفع قيمة الفارق بين سعر الجهازين.

(د) يجب أيضاً نسبة التحمل للمستفيد بشكل تفصيلي قبل تقديم الخدمة بناء على الوثيقة.

(ز) يجب تمكين المؤمن له من التعرف على تكاليف كل خدمة صحية قدمت له عند طلبه.

(ر) يجب تزويد المؤمن له بفاتورة الخدمات الصحية المقدمة.

(س) يحق للمؤمن له الحصول على عرض قيمة التكاليف المتوقعة ومبلغ المشاركة بالدفع قبل البدء بالعلاج.

(ش) يتم احتساب نسبة التحمل على صافي قيمة الفاتورة الطبية، ويستثنى من ذلك فرق السعر للأدوية المبكرة.

(14) أساس تعويض البذل:

(أ) في الحالات الطارئة يجوز للشخص المؤمن له الحصول على المعالجة الطبية الطارئة خارج شبكة مقدمي الخدمة المتفق عليها مع شركة التأمين، ويكون ذلك على أساس تعويض البذل. وفي هذه الحالة تقوم شركة التأمين وفقاً لأحكام الوثيقة وشروطها وتحديداتها واستثناءاتها، بتعويض حامل الوثيقة خلال مدة لا تزيد عن (15) يوم عمل عن النفقات القابلة للاستعاضة حسب الأسعار السائدة، شريطة تزويد شركة التأمين خلال مدة لا تزيد عن (30) يوم عمل من تاريخ تكبد تلك النفقات، بالمستندات المؤيدة التي تطلبها شركة التأمين.

(ب) يحق للمستفيد ترقية فئته التأمينية لفئة تأمينية أعلى وفقاً لأحكام عقد شركة التأمين مع صاحب العمل أو العائل، وفي هذه الحالة يجب على المستفيد أن يدفع الفرق المادي بين فئته التأمينية والفئة التأمينية الأعلى في حال الموافقة.

(15) الموافقات:

بناء على المادة (90) من اللائحة التنفيذية، على أطراف العلاقة التأمينية، فيما يتعلق بالتزام كل طرف على حدة، العمل بما يلي:

(أ) يجب على مقدم الخدمة، إرسال طلب موافقة تحمل تكاليف العلاج للمستفيدين إلى شركة التأمين خلال خمسة عشر (15) دقيقة كحد أقصى من تعينة الطبيب المعالج للطلب.

(ب) يجب على مقدم الخدمة، عند فرق طلب الموافقة على تقديم العلاج للمستفيدين، التأكد من استيفاء الخدمات الصحية التي ستقدم للمؤمن له لمعايير طلب الموافقة.

(ت) يجب على مقدم الخدمة التأكد من حدود المنافع الفرعية المقدمة للمؤمن له.

(ث) يجب على مقدم الخدمة التأكد من تقديم جميع البيانات والمعلومات الأساسية التي تدعم طلب الموافقة.

(ج) تقوم شركة التأمين بالرد على الطلب المقدم من قبل مقدم الخدمة بشأن الموافقة على تقديم العلاج للمستفيدين خلال مدة لا تزيد على ستين (60) دقيقة من وقت طلب الموافقة كحد أقصى من وقت استلام الطلب، وفي حال عدم الموافقة فيجب توضيح الأسباب رسمياً.

(ح) يجب على مقدم الخدمة الرد على استفسارات شركة التأمين خلال (30) دقيقة من وقت استلام الاستفسار.

(خ) يجب أن لا تتجاوز كامل إجراءات طلب الموافقة العلاجية بين شركة التأمين ومقدم الخدمة عن ستين (60) دقيقة من وقت رفع الطلب.

(16) تعويض النفقات في حادث السير:

(أ) يجب على شركة التأمين التي يتم إبلاغها بحادث السير، أن تقوم بتغطية المستفيد ومتابعة علاجه طبياً وتعد شركة التأمين مسؤولة عن تعويض نفقات المطالبة الطبية الناجمة عن حادث السير سواء كان المستفيد هو الصامد

J.The Insured must be enabled to identify the costs of each health service provided to it upon its request.

K.The Insured must be provided with the invoice for the health services provided.

L.The Insured is entitled to obtain a proposal of the expected value of the costs and the copayment amount before starting the treatment.

M.The deductible shall be calculated on the net value of the medical bill, with the exception of the price difference for innovative medicines.

(14)Reimbursement Basis:

A.In cases of emergency, the Insured may obtain urgent medical treatment in centers other than the agreed upon with the Company on reimbursement basis. In such case, the Company shall, in accordance with the policy terms, conditions, limitations and exclusions, compensate the policyholder within a period not exceeding 15 business days for recoverable costs and expenses on the basis of prevailing prices, provided that it shall provide the Company with the supporting documents it requires within 30 business days as of the date of incurring such expenses.

B.The Beneficiary has the right to upgrade his/her insurance category to a higher one in accordance with the provisions of the Contract of the Insurance Company with the employer or the dependent. In this case, the Beneficiary shall pay the difference between his/her insurance category and the higher insurance category, if approved.

(15)Approvals:

In accordance with Article (90) of the Implementing Regulations, the parties to the insurance relationship, with respect to the obligation of each party individually, shall undertake the following:

A.The service provider shall send a request for approval to cover the cost of treatment for the beneficiaries to the Insurance Company within a maximum of fifteen (15) minutes from the time of filling the application by the physician.

B.The service provider shall, upon applying for approval for providing treatment to beneficiaries, ensure that the health services that will be provided to the Insured meet the criteria for the approval request.

C.The service provider shall ascertain the limits of the subsidiary benefits provided to the Insured.

D.The service provider shall ascertain that all basic data and information that support the approval request are submitted.

E.The Insurance Company shall respond to the request submitted by the service provider for the approval of providing treatment to the Beneficiaries within a period not exceeding sixty minutes (60) from the time of submitting the request for approval. In case of disapproval, the reasons shall be formally clarified.

F.The service provider shall respond to the Insurance Company's queries within 30 minutes of receipt of the query.

G.All procedures related to the request for approving the provision of treatment between the Insurance Company and the service provider shall not exceed 60 minutes from the time of submitting the request.

(16)Compensation for Expenses from a Traffic Accident:

A.The Insurance Company that is notified of the traffic accident shall cover the Beneficiary's costs and follow up its medical treatment. The Insurance Company shall be liable for compensating the expenses of a medical claim resulting from a traffic accident, whether the Beneficiary is the perpetrator or the damaged, provided that the vehicle shall be licensed.

B.The Insurance Company shall replace the Beneficiary (i.e. the injured person) in requesting third parties to pay their proportional share of that claim if such claim expenses are compensable for the injured person, meaning that they are covered under any plan, program, other insurance, etc.

C.The Insurance Company is entitled to recourse against the Beneficiary if it waived the party causing the accident.

(17)Expenses of Complications resulting from a Benefit Treatment:

A.The Insurance Company shall cover any costs for treating the complications arising from a benefit covered by the Policy according to the maximum limit specified herein, unless these complications are arising from negligence or medical error by the service provider, and a proof shall be given under a decision by the ministry of justice, establishing the responsibility of the parties of insurance relationship.

B.The Insurance Company shall calculate the incidence of complications resulting from the treatment of the covered benefits, create an indicator based on the best common medical practices for follow-up, and inform the IA if the indicator is exceeded by one of the service providers.

(18)Reasonable and Ordinary Medical Expenses:

In contrast to the price lists agreed upon between the Insurance Company and the service provider for the services and medical expenses, the approved and customary medical expenses provided for the Beneficiary for emergency health services or outside the medical network are considered according to the level of the medical network assigned to the Insured.

(19)Expenses of Corpse Repatriation to Home Country:

The Insurance Company shall cover all costs of preparation and repatriation of the corpse of the Insured to the home country specified in the employment contract according to the maximum limit specified in the Policy.

(20) Calculating the Amortization of the Benefit Limits

It shall be obligated to calculate the costs of the amortization of the benefit limits for the Insured by calculating the total cost on the Net basis, not the Gross bill.

(21)Personal Hazards

The Insurance Authority shall have the power to determine the hazard criteria for activities likely to involve personal hazards, and shall measure the extent to which it is subject to insurance coverage.

(22)Verification of the insured's Health Condition:

A.The Company has the right to and shall be given the opportunity, by an accredited medical entity, to examine the Insured requesting Recoverable Expenses at the expense of the Company for up to two times within sixty (60) business days following submission of the claim.

B.The Policyholder or the Insured shall cooperate with the Company and allow all necessary measures that may reasonably be required by and paid for by the Company for the purpose of preserving any rights, claims, or legal compensations from third parties. The Policyholder may not assign such rights except with the Company's explicit or implicit consent.

(23)Notices:

A.All notices or other correspondence to the Company between all parties shall be formal.

أو المصدوم بناء على ما ورد في تقرير الحادث الصادر من الجهة المختصة، شريطة أن تكون وسيلة النقل مرخصة.

(ب)تدخل شركة التأمين محل المستفيد (أي الشخص المصاب) في مطالبة الغير بدفع حصتهم النسبية من تلك المطالبة، إذا كانت نفقات المطالبة هذه قابلة للاستعاضة للشخص المصاب، بمعنى أنها مقطوعة بموجب أي خطة أو برنامج أو تأمين آخر أو ما شابه ذلك.

(ت)يحق لشركة التأمين الرجوع على المستفيد إذا تنازل عن الطرف المتسبب بالحادث.

(17) مصاريف المضاعفات الناتجة عن علاج منقعة:

(أ)يجب على شركة التأمين تغطية أي تكاليف لعلاج المضاعفات الناتجة عن منقعة مقطوعة بالوثيقة وفقاً للحد الأقصى المحدد في هذه الوثيقة، ما لم تكن تلك المضاعفات ناتجة عن إهمال أو خطأ طبي من مقدم الخدمة على أن يتم إثبات ذلك بموجب قرار صادر من قبل وزارة العدل يحدد مسؤولية أطراف العلاقة التأمينية.

(ب) يجب على شركة التأمين احتساب نسبة حدوث المضاعفات الناتجة عن علاج المنافع المقطوعة وعمل مؤشر مبني على أفضل الممارسات الطبية المتعارف عليها للمتابعة وإبلاغ الهيئة في حال تجاوز المؤشر من أحد مقدمي الخدمة.

(18) المصاريف الطبية المعقولة والمعتادة:

بخلاف القوائم السعرية المتفق عليها بين شركة التأمين ومقدم الخدمة للخدمات والمصاريف الطبية تعتبر المصاريف الطبية المقبولة والمعتادة المقدمة للمستفيد لخدمات صحية طارئة أو خارج الشبكة الطبية بحسب مستوى الشبكة الطبية المحددة للمؤمن له.

(19) مصاريف إعادة جثمان المتوفى إلى موطنه الأصلي:

يجب على شركة التأمين تغطية جميع تكاليف تجهيز وإعادة جثمان الشخص المؤمن له المتوفى إلى موطنه الأصلي المذكور في عقد العمل ومما للحد الأقصى المحدد في الوثيقة.

(20) احتساب استهلاك حدود المنفعة:

تلتزم شركة التأمين باحتساب استهلاك حدود المنفعة للمؤمن له من خلال احتساب التكلفة الإجمالية على أساس الصافي (Net) وليس الإجمالي (Gross) الفاتورة.

(21) الأخطار الشخصية:

لهيئة التأمين صلاحية تحديد معيار خطورة الأنشطة المحتمل أن ينطوي على ممارستها أخطار شخصية وقياس مدى خضوعها للتغطية التأمينية.

(22) تحقق شركة التأمين عن حالة المؤمن له:

(أ)يحق لشركة التأمين، ويجب أن نتاح لها الفرصة، من خلال جهة طبية معتمدة بفحص المؤمن له الذي قُدمت بشأنه مطالبة عن نفقات قابلة للاستعاضة على حسابها بحد أقصى مرتان، وذلك خلال مدة لا تزيد عن (60) يوم عمل من تاريخ تسلم المطالبة.

(ب)على حامل الوثيقة أو المؤمن له، أن يتعاون ويسمح بالقيام، على نفقة شركة التأمين، بالأعمال الضرورية التي تطلبها شركة التأمين في حدود المعقول بقصد تعزيز أية حقوق أو مطالبات أو تعويضات قانونية من الغير، تثبت مسؤوليته عنها. ولا يجوز لحامل الوثيقة أو المؤمن له أن يتنازل عن الحقوق المالية إلا بموافقة شركة التأمين الصريحة أو الضمنية.

(23) الإشعارات:

(أ)يجب أن تكون جميع الإشعارات أو المخاطبات بين أطراف العلاقة التأمينية بصفة رسمية.

(ب)يجب على شركة التأمين إشعار حامل الوثيقة بتاريخ تجديد أو انتهاء الوثيقة كما يلي:

1. بإرسال إشعار تذكير أولي لحامل الوثيقة قبل انتهاء الوثيقة بمدة لا تقل عن 60 يوم.
2. بإرسال إشعار تذكير ثاني لحامل الوثيقة قبل انتهاء الوثيقة بمدة لا تقل عن 30 يوم.
3. بإرسال إشعار تذكير ثالث لحامل الوثيقة قبل انتهاء الوثيقة بمدة لا تقل عن 15 يوم مع إخطار الهيئة بذلك.

(ت)المؤمن له (حامل الوثيقة) ملزم بإشعار شركة التأمين عند تغير أي من بيانات الاتصال الخاصة به والتابعين له.

(24) نموذج الإفصاح الطبي:

تلتزم شركة ميدغلف بنموذج الإفصاح الطبي الموحد المعتمد من قبل هيئة التأمين. ويلتزم حامل الوثيقة بتقديم هذا النموذج. ويجوز لشركة ميدغلف طلب بيانات إضافية علاوة على ما هو وارد في هذا النموذج أو التنازل عن طلب تعبئة كل أو بعض هذه البيانات. بعد أن يتم تعبئته من قبل المستفيد نفسه.

(أ) بالنسبة لحاملي الوثائق الذين يقل عدد موظفيهم عن مائة (100) موظف، يجب تعبئة نموذج الإفصاح الطبي لجميع الأعضاء.

(ب) بالنسبة لحاملي الوثائق الذين يبلغ عدد موظفيهم مائة (100) موظف أو أكثر، يُشترط تقديم نموذج الإفصاح الطبي فقط للأعضاء الذين تجاوزت أعمارهم خمساً وستين (65) سنة بالإضافة إلى المستفيدين الذين يتم إضافتهم بعد بدء سريان الوثيقة.

(25) التقيد بأحكام الوثيقة:

إنه لمن الشروط السابقة لتحقيق أي التزام على شركة التأمين أن يكون حامل الوثيقة والأشخاص المؤمن لهم قد تفقوا وتقبلوا تماماً بجميع الاشتراطات والشروط والواجبات والالتزامات الواردة في هذه الوثيقة.

(26) التفسير والتأويل:

ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك أو تم النص على خلافه صراحة، فإن:

- أ. أي إشارة إلى المذكر تشمل في دلالتها المؤنث.
- ب. أي إشارة إلى هذه الوثيقة وتشمل أي تعديلات قد تطرأ عليها أو على الأنظمة ذات العلاقة الأخرى.

(27) الجراءات:

أي خلاف أو نزاع ينشأ أو يتعلق بهذه الوثيقة يتم الفصل فيه بموجب أحكام النظام ولائحته التنفيذية وذلك وفقاً للمادة (14) من النظام.

B.The Insurance Company shall notify the Policyholder with the Policy renewal or expiry date as follows:

- 1.Sending a preliminary reminder notice to the Policyholder prior to the Policy expiration date of not less than 60 days.
- 2.Sending a second reminder notice to the Policyholder prior to the Policy expiration date of not less than 30 days.
- 3.Sending a third reminder notice to the Policyholder prior to the Policy expiration date of not less than 15 days, and notifying the IA of it.

C.The Insured (Policyholder) shall be obligated to notify the Insurance Company whenever any of its contact information, or of its subsidiaries, is changed.

(24) Medical Declaration Form:

Medgulf Company shall adhere to the Unified medical declaration form approved by the IA. The policyholder is required to submit this form. Medgulf may request additional data in addition to what is included in this form, or waive the request to fill out all or some of this data, duly completed by the member himself.

(A) For policyholders with fewer than one hundred (100) employees, the medical declaration form must be completed for all members.

(B) For policyholders with one hundred (100) employees or more, the medical declaration form is required only for members aged over sixty-five (65) years, in addition to the added insured after the policy's inception.

(25) Compliance with Policy Provisions:

As a precondition to any liability of the company, the Policyholder and beneficiaries shall strictly comply with and execute all requirements, conditions, obligations and commitments stated in this Policy.

(26) Construction:

Unless the context otherwise required, or expressly stated the opposite:

A.Any reference to a masculinity shall include femininity in its meaning.

B.Any reference to this Document shall include in its meaning any amendments hereto or relating bylaws.

(27) Penalties:

Any disagreement or dispute arising out of or relating to the Policy shall be settled in accordance with Article (14) of the Cooperative Health Insurance Law.

Network

الشبكة

A. Minimum Network: It refers to the network of service providers that covers all Kingdom's regions and cities and its geographical scope, provided that it shall include all levels of health service.

B. Preferred Providers Network (PPN): A group of health service providers approved by the IA and identified by the Health Insurance Company to provide the service to the Insured. This is done directly by debiting the Insurance Company's account, provided that this network shall ensure the following levels of health services:

- Level One (Primary health care).
- Level Two (Public Hospitals).
- Level Three (Specialized or Reference Health Care).

Other complementary health services centers (such as: One-day surgery centers, pharmacies, Physical Therapy Centers, optical stores)

C. The Insurance Company shall provide the minimum network according to the Law of the Insurance Authority, taking into account that, when designing the minimum network, that government health facilities are included within the network for Saudi Beneficiaries for policies in accordance to article 11.

D. The Insurance Company shall provide the following specialized centers within the network: accident centers, heart and stroke centers, advanced centers for the treatment of tumors, advanced centers for the treatment of neurosurgery and chest, centers of critical care units for newborns and premature infants, in addition to the centers for high-risk pregnancy.

E. Diversity of Medical Network: The Policyholder may request the Insurance Company to expand the medical network for the minimum network approved by the IA, provided that the expansion shall commensurate with the distribution of Beneficiaries

F. Quality of Medical Network: The Insurance Company shall provide the relevant specialties that mainly serve the Beneficiary in the design of the minimum network, provided that the IA shall, in the future, determine the specialties that must be available in the minimum network.

G. Telemedicine: The Insurance Company shall provide, within the minimum network, a Telemedicine service according to the classification of service providers approved by the IA to provide this service.

H. The Insurance Company may, in the event of non-approval to continue treatment in emergency cases, transfer the Insured, after the stabilization of health condition, to a service provider within the PPN of the Insured.

I. The Insurance Company may not, in the event of a transfer to another service provider, obligate the Insured to a specific service provider, as the Insured has the right to choose from its PPN.

J. The Insurance Company shall pay the claims directly to the non-contracted service provider for the period spent by the Insured to receive emergency treatment, based on the prices agreed upon with another health service provider of the same level and classification on the network.

K. The service provider shall provide health care services to those covered by any valid health insurance policies before the expiry or cancellation of the contract until the end of the insurance year as long as it is within the Preferred health care provider network for the Insured

a. the Company bearing the responsibility to update the eligibility of the Beneficiary according to the start and end of the policies, which entails providing the service and claims accordingly.

L. Following the issuance of the Policy to the Employer, the Insurance Company may not delete or replace a health service provider from the medical network specified for it during the validity period of the Policy unless:

i. The Company observed a fundamental breach in the provision of the service from the health service provider, such as fraud or upon termination of the contract by the health service provider,

ii. or suspension/cancellation of its approval by the IA.

a. The company shall provide a substitute the deleted provider at the same level in coordination with the Policyholder, taking into account the specified warning period as well as the terms of cancellation stipulated in the contract concluded between them.

b. The Insurance Company shall notify the IA upon the replacement of a service provider from an insurance category to another.

M. The Company shall provide an adequate network of health service providers in terms of numbers and types of health care providers to ensure access to all health care services provided to beneficiaries without delay.

N. The insurance company is obligated to provide the Insurance Authority with an annual report on the minimum network, which includes a list of covered service providers, the speed of subscribers' access to services, the geographical availability of service providers to beneficiaries, the number of providers of categories of service providers for each subscriber

O. The Insurance Company shall provide a service provider network that meets the following access requirements, provided that it shall be determined based on the geographical scope and which shall be related to the national address of the Insured. The below conditions are indicative on determining the service provider network, and the IA shall later set the necessary condition:

1. For urban areas, a service provider network available to all Beneficiaries registered in the Policy within forty-eight (48) km or thirty (30) minutes from each person's place of residence or work, according to the availability of service providers approved by the IA in the region.

2. For areas other than urban areas (remote areas), the service provider network shall provide the services of primary health care doctors, hospital services and pharmacy within thirty (30) minutes or forty-eight (48) km from the place of residence or work of each registrant, according to the availability of service providers approved by the IA in the region. Provided that the services of other specialties shall be provided to all Beneficiaries registered in the policy within fifty (50 minutes) or eighty (80) km from the place of residence or work of each registrant, according to the availability of service providers approved by the IA in the region.

Annex to the Policy

(أ) شبكة الحد الأدنى: هي شبكة مقدمي الخدمة التي تغطي كافة مناطق ومدن المملكة ونطاقها الجغرافي على أن تتضمن كافة مستويات الخدمة الصحية.

(ب) شبكة مقدمي الخدمة المفضلة: مجموعة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين من الهيئة والمحددن من قبل شركة التأمين الصحي لتقديم الخدمة للمؤمن له ويتم ذلك بالقيود مباشرة على حساب شركة التأمين على أن يتضمن هذه الشبكة مستويات الخدمات الصحية التالية:

- المستوى الأول (الرعاية الصحية الأولية).
- المستوى الثاني (المستشفيات العامة).
- المستوى الثالث (الرعاية الصحية التخصصية أو المرجعية).

- مراكز تقديم الخدمات الصحية الأخرى المكتملة (مثل: مراكز جراحة اليوم الواحد، الصيدليات، مراكز العلاج الطبيعي، محلات النظارات).

(ت) تلتزم شركة التأمين بتقديم شبكة الحد الأدنى حسب نظام هيئة التأمين مع الأخذ في الاعتبار عند تصميم شبكة الحد الأدنى إضافة المرافق الصحية الحكومية للمستفيدين السعوديين بحسب نظام المادة 11.

(ث) تلتزم شركة التأمين بتقديم شبكة الحد الأدنى حسب نظام هيئة التأمين مع الأخذ في الاعتبار عند تصميم شبكة الحد الأدنى بتوفير أعداد وأنواع مقدمي رعاية صحية كافية لضمان إمكانية الوصول إلى جميع خدمات الرعاية الصحية المقدمة إلى المستفيدين دون تأخير.

(ج) تلتزم شركة التأمين بتوفير المراكز التخصصية التالية ضمن الشبكة: مراكز الحوادث، مراكز القلب والخطوات، مراكز متطورة لعلاج الأورام، المراكز المتطورة لعلاج جراحة الأعصاب والصدر، مراكز وحدات العناية الحرجة للمواليد والحدج بالإضافة لمراكز الحمل عالي الخطورة.

(ح) تنوع الشبكة الطبية: يحق لحام الوثيقة الطلب من شركة التأمين توسعة الشبكة الطبية عن شبكة الحد الأدنى التي أقرها الهيئة مع مراعاة أن تكون متناسبة مع توزيع المستفيدين الجغرافي.

(خ) نوعية الشبكة الطبية: تلتزم شركة التأمين بتوفير التخصصات ذات العلاقة والتي تخدم المستفيد بشكل أساسي في تصميم شبكة الحد الأدنى على أن تقوم الهيئة مستقبلا في تحديد التخصصات التي يجب توفرها في شبكة الحد الأدنى.

(د) تلتزم شركة التأمين بتوفير خدمة الطب الإحصائي حسب تصنيف مقدمي الخدمة المعتمدين من الهيئة لتقديم هذه الخدمة ضمن شبكة الحد الأدنى.

(ذ) يحق لشركة التأمين في حال عدم الموافقة على مواصلة العلاج للحالات الطارئة خارج الشبكة نقل المؤمن له بعد استعجال حالته الصحية إلى مقدم خدمة داخل شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة للمؤمن له.

(ر) لا يحق لشركة التأمين في حال وجود طلب التحويل لمقدم خدمة آخر إلزام المؤمن له بمقدم خدمة محدد حيث يحق للمؤمن له الاختيار من ضمن شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة له.

(ز) تلتزم شركة التأمين بسداد المطالبات بشكل مباشر لمقدم الخدمة غير المتعاقد معه عن الفترة التي قضاه المؤمن له لتلقي علاج الحالات الطارئة وذلك بناء على الأسعار المتفق عليها مع مقدم خدمة صحية آخر بنفس المستوى والتصنيف على شبكة المؤمن له.

(س) يلتزم مقدم الخدمة بتقديم خدمات الرعاية الصحية للمشمولين بأي وثائق تأمين صحي سارية قبل الانتهاء أو الإلغاء للعقد حتى انتهاء السنة التأمينية طالما أنها ضمن شبكة مقدمي الرعاية الصحية المعتمدة للمؤمن لهم مع تحمل شركة التأمين المسؤولية بتحديث أهلية المستفيد وفقا لبدا وانتهاء الوثائق والتي يترتب عليها تقديم الخدمة والمطالبات وفقا لذلك.

(ش) لا يحق لشركة التأمين بعد إصدار الوثيقة لصاحب العمل حذف أو استبدال مقدم خدمة صحية من الشبكة الطبية المحددة له خلال فترة سريان الوثيقة إلا إذا لمست من مقدم الخدمة الصحية إخلالا جوهريا بتقديم الخدمة كالقيام بالاحتيال أو عند إنهاء التعاقد من قبل مقدم الخدمة الصحية أو تعليق/إلغاء اعتماده من قبل الهيئة، على أن يقوم بتوفير بديل عنه بنفس المستوى بالتنسيق مع حامل الوثيقة، مع مراعاة مهلة الإنذار المحددة وكذلك شروط الإلغاء المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما، و في حال حذف مقدم خدمة من شبكة الحد الأدنى فإنه يستمر في استقبال الوثائق السارية المعتمدة في السابق و حتى تاريخ انتهائها. وتلتزم شركات التأمين بإخطار الهيئة عند استبدال مقدم خدمة من فئة تأمينية إلى أخرى.

(ص) تلتزم شركة التأمين بتوفير شبكة كافية من مقدمي الخدمة الصحية من حيث أعداد وأنواع مقدمي الرعاية الصحية لضمان إمكانية الوصول إلى جميع خدمات الرعاية الصحية المقدمة إلى المستفيدين دون تأخير.

(ض) تلتزم شركة التأمين بتزويد هيئة التأمين بتقرير سنوي عن شبكة الحد الأدنى وتشمل قائمة بمقدمي الخدمة المشمولين، سرعة وصول المشتركين للخدمات، التوافر الجغرافي لمقدمي الخدمات للمستفيدين، عدد مقدمي الخدمة من الفئات المختلفة لكل مشترك.

(ط) على شركة التأمين توفير شبكة مقدمي خدمة تبلي متطلبات الوصول التالية، على أن يتم تحديثها بناء على النطاق الجغرافي والمرتبطة بالعنوان الوطني للمؤمن له والاشتراطات أدناه هي استرشادية على تحديد شبكة مقدم الخدمة وستقوم الهيئة لاحقا بوضع الاشتراطات اللازمة:

(1) للمناطق الحضرية، شبكة مقدمي خدمة متاحة لجميع المستفيدين المسجلين في الوثيقة تبعد ثمانية وأربعون (48) كم أو تستغرق ثلاثين دقيقة للوصول كحد أقصى من مكان إقامة كل شخص أو عمله، بحسب توافر مقدمي الخدمة المعتمدين من الهيئة بالمنطقة.

(2) للمناطق الأخرى غير المناطق الحضرية (المناطق النائية)، توفر شبكة مقدمي الخدمة خدمات أطباء الرعاية الأولية وخدمات المستشفيات والصيدلة لجميع المستفيدين المسجلين في الوثيقة تبعد ثمانية وأربعون (48) كم أو تستغرق ثلاثين دقيقة للوصول كحد أقصى من مكان إقامة أو عمل كل المسجلين في الوثيقة، بحسب توافر مقدمي الخدمة المعتمدين من الهيئة بالمنطقة. على أن يتم توفير خدمات التخصصات الأخرى لجميع المستفيدين المسجلين في الوثيقة تبعد ثمانون (80) كم أو تستغرق خمسين (50) دقيقة للوصول كحد أقصى من مكان إقامة أو عمل كل مؤمن له بحسب توافر مقدمي الخدمة المعتمدين من الهيئة بالمنطقة.

ملحق الوثيقة

This chapter contains a set of appendices that are deemed as an integral part hereof, contain instructions and procedures related to the implementation of this policy. These appendices shall include the documents referred to in the articles hereof as follows:

- 1.Preventive Procedures approved by the Ministry of Health Appendix # (1)
- 2.National Vaccination Schedule (for Children) issued by the Ministry of Health Appendix # (2)
- 3.Schedule of the National Newborn Screening Program to eliminate disabilities Appendix # (3)
- 4.Services Provided for Autism management Appendix # (4)
- 5.Controls governing coverage of baby milk Appendix # (5)
- 6.Schedule of Respiratory Syncytial Virus (RSV) Immunizations issued by the Ministry of Health Appendix # (6)
- 7.Providers Minimum Network Appendix # (7)
8. Declaration Form Appendix # (8)
- 9.Clinical guidelines and benefit Bundles Appendix # (9)

To view the details of the annexes and for more information regarding the Unified Insurance Authority, please visit <https://www.ia.gov.sa/Regulations/health-insurance-laws-regulations-circulars.html>

يحتوي هذا القسم على مجموعة ملاحق تعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة، وتحتوي على التعليمات والإجراءات ذات العلاقة بتطبيق هذه الوثيقة، وتشمل هذه الملاحق المستندات المشار إليها في مواد هذه الوثيقة على النحو التالي:

- 1.ملحق الوثيقة رقم (1) الإجراءات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة
- 2.ملحق الوثيقة رقم (2) جدول التطعيمات الأساسية الصادر عن وزارة الصحة
- 3.ملحق الوثيقة رقم (3) جدول البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الاعاقة
- 4.ملحق الوثيقة رقم (4) الخدمات المقدمة لمرضى التوحد
- 5.ملحق الوثيقة رقم (5) ضوابط الاحتياج لصرف حليب الأطفال الرضع المحتاجين إليه طياً حتى عمر 24 شهر
- 6.ملحق الوثيقة رقم (6) جدول تحصينات الفيروس التنفسي المكروي المعتمدة الصادر عن وزارة الصحة
7. ملحق الوثيقة رقم (7) الحد الأدنى لشبكة مقدمي الخدمة الصحية
- 8.ملحق الوثيقة رقم (8) نموذج الإفصاح الطبي
- 9.ملحق الوثيقة رقم (9) الأدلة الاكتينية وحزم المنافع

للإطلاع على تفاصيل الملاحق و مزيد من المعلومات بما يخص وثيقة هيئة التأمين يرجى زيارة <https://www.ia.gov.sa/Regulations/health-insurance-laws-regulations-circulars.html>

6) Global Emergency Services

This policy covers global emergency services through Assist America when traveling abroad or if located within 150 kilometers radius from permanent residence.

(1) Services provided abroad:

- Medical Consultation, Evaluation & Referral:
Calls to "Assist America" Operations Center are evaluated by medically certified personnel and referred to qualified doctors and/or hospitals.
- Hospital Admission Guarantee:
Assist America fosters prompt hospital admission by validating the participant's health coverage or by advancing funds to the hospital as needed.
- Emergency Medical Evacuation:
If adequate medical facilities are not available locally, "Assist America" will provide the required mode of transportation, equipment, and personnel necessary to complete the beneficiary's evacuation to the nearest medical facility.
- Critical Care Monitoring:
"Assist America" medical personnel will maintain regular communication with the beneficiary's attending physician and/or hospital and relay full information to the family.
- Medically Supervised Repatriation:
If a beneficiary still requires medical assistance upon being discharged from a hospital, "Assist America" will repatriate him/her to the country of residence or to a rehabilitation facility accompanied by a medical or non-medical escort, as necessary.
- Prescription Assistance:
If a beneficiary needs a replacement prescription while traveling, "Assist America" will help in providing that prescription.
- Emergency Message Transmission:
"Assist America" will receive and transmit emergency messages to the beneficiary.
- Compassionate Visit:
If a beneficiary is traveling alone and will be hospitalized for more than five days, "Assist America" will provide economy, round-trip ticket through a common carrier transportation to the hospitalization location for a designated family member or friend.
- Care of Minor Children:
"Assist America" will arrange childcare for unattended minors due to any medical emergency and pay for any transportation costs incurred in such arrangements.
- Return of Remains:
"Assist America" will render every possible assistance in the event of a beneficiary's death. This service includes the remains transfer arrangements, procuring the required documentation, providing the necessary shipping container as well as bearing the transfer expenses.
- Lost Luggage or Document Assistance:
"Assist America" will help the beneficiary locate lost luggage, documents, or personal belongings.
- Interpreter & Legal Referrals:
"Assist America" will refer participants to legal interpreters, as necessary.
- Pre-trip Information:
"Assist America" offers the beneficiary web-based country profiles that include visa requirements, immunization, and inoculation recommendations, as well as security guidelines for any travel destination.

(2) Conditions & Exclusions:

6) خدمات الطوارئ العالمية

هذا العقد يشمل تغطية الخدمات الطارئة في الخارج من خلال شركة "أسست أميركا" أثناء السفر أو التواجد في المناطق التي تتجاوز 150 كيلومتر من مكان الإقامة.

(1) الخدمات التي تغطي في الخارج:

- الاستشارة والتقييم الطبي والتحويل:
تقيم الاتصالات بمركز عمليات "أسست أميركا" بواسطة موظفين مؤهلين طبيًا، بالإضافة للتحويل إلى أطباء مؤهلين و/أو مستشفيات.
- ضمان دخول المستشفى:
"أسست أميركا" تتكفل بحالات الدخول العاجل إلى المستشفيات، إما بالتصديق على التغطية الصحية للمستفيد أو بدفع المبلغ المطلوب من المستشفى مقدماً بحسب الحاجة.
- الإخلاء الطبي الطارئ:
في حالات عدم توفر الوسائل الطبية اللازمة محلياً، فإن "أسست أميركا" ستوفر وسيلة النقل اللازمة والمعدات والأشخاص المعنيين لإتمام عملية الإخلاء الطبي للمستفيد إلى أقرب مرفق طبي.
- رقابة العناية الحرجة:
يبقى موظفي "أسست أميركا" الطبيين على تواصل منتظم مع الطبيب المباشر للحالة و/أو مع المستشفى لنقل كافة المعلومات إلى عائلة المستفيد.
- الإشراف الطبي للعودة إلى الوطن:
في حال حاجة المستفيد إلى المساعدة الطبية بعد خروجه من المستشفى، فإن "أسست أميركا" تتكفل بإعادته إلى الوطن أو إلى أي مركز تأهيل آخر بمرافقة مختص طبي أو غير طبي بحسب الحاجة.
- المساعدة الوصفية:
في حالة حاجة المستفيد إلى أية وصفة بديلة أثناء سفره، فإن "أسست أميركا" ستساعد في تأمين هذه الوصفة.
- نقل الرسائل الطارئة:
"أسست أميركا" ستقوم باستقبال ونقل الرسائل الطارئة للمستفيد.
- الزيارة الرحيمة:
في حال لم يكن المستفيد برفقة أحد خلال سفره واستدعت الحالة المرضية التنويم في المستشفى لمدة تتجاوز خمسة أيام، فإن "أسست أميركا" ستقدم تذكرة سفر اقتصادية ذهاباً وإياباً عبر ناقل متعهد إلى مكان التنويم لشخص مختار من العائلة أو الأصدقاء.
- العناية بالأطفال الفاصرين:
"أسست أميركا" سترتب للعناية بالأطفال الفاصرين والذين استدعت الحالة لتركهم بدون صحة نتيجة ظرف طبي طارئ، كما ستقوم بالتكفل بنفقات النقل المترتبة.
- إعادة الجثمان:
"أسست أميركا" ستقدم كل المساعدة الممكنة في حال وفاة المستفيد (لا قدر الله). تشمل هذه الخدمة ترتيبات نقل الرفات، تحصيل المستندات المطلوبة وتوفير وسيلة الشحن اللازمة، بالإضافة إلى تكاليف النقل.
- فقدان الحقائب أو المساعدة المستتدة:
"أسست أميركا" ستساعد المستفيد في تحديد مكان الأمتعة المفقودة، الوثائق أو الأمتعة الشخصية.
- المترجم والتحويلات النظامية:
"أسست أميركا" ستقوم بتحويل المستفيد إلى مترجمين قانونيين عندما تستدعي الحاجة.
- معلومات ما قبل الرحلة:
"أسست أميركا" ستعرض للمستفيد لمحة توضيحية عن البلد تتضمن متطلبات التأشيرة، اللقاحات والتطعيمات الوقائية الموصى بها، بالإضافة إلى الإرشادات الأمنية لوجهة السفر.

(2) الشروط والاستثناءات الخاصة:

تخضع هذه التغطية للاستثناءات التالية:

This service is subject to the following exclusions:

- Travel commenced specifically for medical treatment.
- Injuries resulting from participation in acts of political demonstration, war or insurrection.
- Illegitimate or antiregime act(s) or practices.
- Suicidal attempts.
- Incidents involving drug abuse unless prescribed by a physician.
- Transfer of Participant from one medical facility to another medical facility of similar capabilities and providing a similar level of care.

"Assist America" will not evacuate or repatriate a beneficiary in the following cases:

- Without medical authorization.
- With mild lesions, simple injuries such as sprains, simple fractures, or mild sickness which could be treated by local doctors and does not prevent the beneficiary from continuing his trip or returning home.
- Pregnancy over six months.
- Suffering mental or nervous disorders unless hospitalized.

(3) General Exclusions:

- Trips exceeding 90 days away from the legal residence and without prior notification to "Assist America".
- "Assist America" provides worldwide support services. Transportation response time depends directly on the location and jurisdiction where an emergency occurs. "Assist America" is not responsible for any failure to provide services or for delays in delivering medical services caused by force majeure, including but not limited to weather conditions, availability of airports, flight conditions, availability of hyperbaric chambers, communication systems, or where rendering of service is limited or prohibited by local law or edict.
- All physicians and consulting attorneys are independent contractors that are not under the control of "Assist America". "Assist America" is not responsible or liable for any malpractice committed by professionals rendering services to a beneficiary.

All benefits are subject to the terms, conditions and exclusions of this policy.

- السفر بغرض العلاج الطبي
- الإصابات الناجمة عن مشاركة في مظاهرة أو حرب أو عصيان مسلح
- الأعمال والممارسات غير الشرعية أو غير النظامية
- محاولة الانتحار
- الحوادث الناتجة عن تعاطي المخدرات ما لم توصف من قبل طبيب
- نقل المستفيد من مرفق طبي إلى آخر بنفس المستوى من الكفاءة والعناية الصحية

"أسست أميركا" لن تقوم بأي إخلاء أو إعادة أي مستفيد في الحالات التالية:

- إذا كان غير مخول طبياً
- إذا كان يعاني من جروح طفيفة، أو إصابات بسيطة مثل الإلتواءات، الكسور البسيطة، أو أي مرض يمكن معالجته من قبل الأطباء المحليين ولا يمنع المستفيد من استمرار رحلة سفره أو إرجاعه إلى وطنه
- في حالة الحمل لأكثر من ستة أشهر
- إذا كان يعاني من اضطرابات عقلية أو عصبية ما لم يتم في المستشفى

(3) الاستثناءات العامة:

الرحلات التي تتجاوز مدتها 90 يوماً خارج مكان الإقامة القانوني وبدون إخطار مسبق لـ "أسست أميركا".

"أسست أميركا" توفر خدمات المساعدة في جميع أنحاء العالم. يعتمد الوقت المعلن للنقل بشكل مباشر على الموقع والسلطات القضائية في مكان حدوث الحالة الطارئة. "أسست أميركا" لن تكون مسؤولة عن أي إخفاق في تقديم الخدمات أو التأخيرات في تقديم الخدمة الصحية إذا كانت ناتجة عن ظروف خارجة عن سيطرتها، يتضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الأحوال الجوية، توافر المطارات، ظروف رحلات الطيران، توافر الغرف عالية الضغط، أنظمة الاتصالات، أو حيث يكون تقديم المساعدة محدود أو ممنوع بقانون أو مرسوم محلي.

- جميع الأطباء والمحامين الاستشاريين هم متعاقدون مستقلون وليسوا خاضعين لسيطرة "أسست أميركا"، وبالتالي "أسست أميركا" لن تكون مسؤولة أو متحملة لأي خطأ قد يصدر عن الأشخاص المعنيين بتقديم الخدمات للمستفيدين.

تخضع جميع هذه المنافع لبنود وشروط واستثناءات هذا العقد.



نؤمن لك حياة افضل

We Insure You A Better Life

حمّل التطبيق الآن
لمعرفة المزيد عن خدماتنا

Download the MEDGULF app
to explore all our services



